Reglas EPC por Aprendizaje - Documento Completo

Este documento contiene TODOS los feedbacks de los evaluadores médicos, sin omisiones. Se actualiza de forma INCREMENTAL: cada nuevo feedback se agrega al documento.

Información General

Dato	Valor
Total Feedbacks	342
Última Actualización	06/02/2026 17:31
Secciones Evaluadas	7

Resumen Estadístico por Sección

Sección	Total	OK	Parcial	Malo	% Negativo	Omisiones	Repeticiones	Confuso
Motivo de Internación	56	22	21	13	60%	5	9	8
Evolución	47	3	21	23	93%	18	4	14
Procedimientos	48	13	21	14	72%	8	9	11
Interconsultas	47	16	10	21	65%	7	8	11
Medicación	47	6	20	21	87%	9	15	20
Indicaciones de Alta	52	23	19	10	55%	9	0	3
Recomendaciones	45	19	17	9	57%	6	5	8

Reglas Aprendidas (Generadas Automáticamente)

Las siguientes reglas se generaron automáticamente basándose en patrones del feedback:

1. **Recomendaciones** Evitar OMISIONES - 6 casos reportados
2. **Recomendaciones** Evitar REPETICIONES - 5 casos reportados
3. **Recomendaciones** Evitar contenido CONFUSO/ERRÓNEO - 8 casos reportados
4. **Indicaciones de Alta** Evitar OMISIONES - 9 casos reportados
5. **Indicaciones de Alta** Evitar contenido CONFUSO/ERRÓNEO - 3 casos reportados
6. **Medicación** Evitar OMISIONES - 9 casos reportados
7. **Medicación** Evitar REPETICIONES - 15 casos reportados
8. **Medicación** Evitar contenido CONFUSO/ERRÓNEO - 20 casos reportados
9. **Interconsultas** Evitar OMISIONES - 7 casos reportados
10. **Interconsultas** Evitar REPETICIONES - 8 casos reportados
11. **Interconsultas** Evitar contenido CONFUSO/ERRÓNEO - 11 casos reportados
12. **Procedimientos** Evitar OMISIONES - 8 casos reportados
13. **Procedimientos** Evitar REPETICIONES - 9 casos reportados
14. **Procedimientos** Evitar contenido CONFUSO/ERRÓNEO - 11 casos reportados
15. **Evolución** Evitar OMISIONES - 18 casos reportados
16. **Evolución** Evitar REPETICIONES - 4 casos reportados
17. **Evolución** Evitar contenido CONFUSO/ERRÓNEO - 14 casos reportados
18. **Motivo de Internación** Evitar OMISIONES - 5 casos reportados
19. **Motivo de Internación** Evitar REPETICIONES - 9 casos reportados
20. **Motivo de Internación** Evitar contenido CONFUSO/ERRÓNEO - 8 casos reportados

Total de reglas activas: 20

Detalle Completo de Feedbacks por Sección

A continuación se presenta CADA feedback individual recibido, agrupado por sección.

Motivo de Internación

Estadísticas: - Total: 56 evaluaciones - OK: 22 | Parcial: 21 | Malo: 13 - Omisiones: 5 | Repeticiones: 9 | Confuso: 8

Feedbacks Individuales (56 registros):

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
1	28/01/2026 16:09	partial	-	Sí	Sí	Solamente correposnde debilidad de miembros inferiores
2	28/01/2026 01:21	bad	Sí	Sí	Sí	Corresponde que diga "Neurocirugía programada: resección de recidiva de glioma de alto grado parietal derecho". El resto no corresponde aclarar. No se debe escribir todo en mayúsculas
3	27/01/2026 21:30	partial	Sí	Sí	-	Retención aguda de orina es un diagnostico medico, el paciente consulta pro hematuria como se especifico y ademas polaquiuria y tenesmo vesical.
4	27/01/2026 12:55	ok	-	-	-	-
5	27/01/2026 12:55	ok	-	-	-	-
6	27/01/2026 12:55	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
7	27/01/2026 03:15	bad	Sí	-	Sí	El paciente ingresa directamente a UCI. La epicrisis de alta calidad debe dar una idea clara de la gravedad del cuadro. En este caso el resumen de ingreso es sepsis a foco de piel y partes blandas a p
8	26/01/2026 22:30	ok	-	-	-	-
9	26/01/2026 17:34	bad	-	-	Sí	Frenulotomia programada deberia decir
10	26/01/2026 15:13	ok	-	-	-	-
11	26/01/2026 14:07	bad	-	Sí	-	El motivo de internación es la ablación programada. el resto es una complicación del procedimiento.
12	24/01/2026 14:35	bad	-	Sí	-	Muy largo. Con “cirugía programada” o “Cirugía por recidiva de glioma de alto grado” es suficiente.
13	23/01/2026 23:31	partial	-	Sí	Sí	Solo se debe describir lo que motivó a la internación del paciente. En este caso resección neuroquirúrgica programada de recidiva de glioblastoma cerebral
14	23/01/2026 21:23	ok	-	-	-	-
15	23/01/2026 13:00	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
16	23/01/2026 12:34	partial	-	-	Sí	Aquí el motivo de internación es cirugía programada. Siempre que se trate de un paciente que ingresa para un procedimiento quirúrgico se debe aclarar “cirugía programada de (lo que corresponda)”
17	23/01/2026 12:19	partial	Sí	-	-	Le falta agregar que tuvo dorsalgia y fiebre. Si bien no está en el ingreso, lo agrega en evoluciones posteriores y es importante para el cuadro clínico actual
18	22/01/2026 21:38	partial	-	Sí	-	Generalmente no se aclara mucho en el motivo de internación se pone el motivo que lo motivo a consultar principalmente o internarse. La aclaración de cirugía reciente corresponde a la evolución
19	22/01/2026 20:36	partial	Sí	-	-	Muchas veces se aclara que es una cirugía programada ya que no es lo mismo que sea programada que sea de urgencia. De todos modos no esta mal el motivo de internación.
20	22/01/2026 20:33	ok	-	-	-	-
21	21/01/2026 12:15	ok	-	-	-	-
22	20/01/2026 22:25	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
23	20/01/2026 21:46	partial	-	Sí	Sí	No corresponde en esta sección que es traída desde geriátrico
24	20/01/2026 21:14	ok	-	-	-	-
25	20/01/2026 19:40	ok	-	-	-	-
26	20/01/2026 18:39	partial	-	Sí	Sí	En este caso la internación fue programada para la resección del tumor de la glándula pineal. La hidrocefalia y compromiso del tercer ventrículo es un antecedente, que previamente motivó la colocación
27	20/01/2026 14:25	bad	-	-	-	diarrea cronica, dolor anal y fiebre. La presencia de fiebre en las ultimas 48hs cambia el cuadro
28	20/01/2026 02:31	ok	-	-	-	-
29	20/01/2026 02:15	bad	-	-	-	inestabilidad a la bipedestación, dificultad para deglutir y alteración de la sensibilidad de 2 años de evolución.
30	20/01/2026 01:38	bad	-	-	-	Lumbalgia invalidante. El pop no es el motivo de internación. Se interna y se define indicación quirúrgica

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
31	19/01/2026 22:49	partial	-	-	-	Se debe incluir los síntomas que motivaron la internación, en este caso la disnea (dato más importante porque se relaciona con el diagnóstico posterior), y asociado la astenia, adinamia y deposiciones
32	19/01/2026 14:57	bad	-	-	-	Tiene varios antecedentes de importancia. No categorizar uno solo. Viene por Falta de aire y mareos. Es importante no sesgarse y atenerse al motivo de consutla si decidimos ese formato de epicrisis o
33	19/01/2026 12:31	ok	-	-	-	-
34	19/01/2026 12:31	ok	-	-	-	-
35	19/01/2026 00:53	partial	-	-	-	El motivo de internación debe ser lo más simple y técnico posible para permitir interpretación correcta sin ambiguedades. En este caso deterioro del sensorio y hematuria sería correcto. Si se quiere
36	19/01/2026 00:32	ok	-	-	-	-
37	19/01/2026 00:18	ok	-	-	-	-
38	18/01/2026 14:41	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
39	17/01/2026 15:44	bad	-	-	-	Dolor abdominal y vómitos, mas corto y sin tanta explicación. El diagnóstico es posterior.
40	17/01/2026 15:42	bad	-	-	-	Dolor abdominal y vómitos
41	17/01/2026 15:14	partial	-	-	-	Disuria, polaquiuria y movimientos anormales.
42	17/01/2026 14:40	partial	-	-	-	Solamente: disnea o disnea + deterioro del estado general
43	17/01/2026 14:14	partial	-	-	-	Solamente "Melena"
44	17/01/2026 13:36	partial	-	-	-	El motivo de internación es el síntoma de la paciente, el diagnóstico de ACV se hace posteriormente. El motivo de internación tiene que se corto y claro. No abreviar, en vez de TEC poner traumatismo
45	17/01/2026 13:14	partial	-	-	-	Se debe tecnificar el lenguaje para evitar malinter-pretaciones. En este caso se podría consignar: retención aguda de orina u oliguria y deterioro del sensorio
46	17/01/2026 12:43	bad	-	-	-	Siempre describir síntomas, signos o síndrome que motiva la internación. No se debe hacer un diagnóstico etiológico si no existe seguridad al respecto. En este caso el motivo de internación fue dolor

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
47	16/01/2026 23:36	partial	-	-	-	Aquí corresponde consignar síndrome febril (dado que incluye las otras manifestaciones como astenia, anorexia, decaimiendo que acompañanan ala fiebre) prolongado (dado que tiene 1 mes de evolución) de
48	16/01/2026 18:11	bad	-	-	-	Inespecifico no. Aporta a la confusión o a un interrogatorio pobre mas que a información util
49	16/01/2026 13:46	partial	-	-	-	No queda clara la perforación intestinal (no se evidencia en laparascopia exploradora). Se podría reducir a dolor abdominal y proctorragia secundaria a traumatismo anal autoinflingido
50	16/01/2026 12:56	partial	-	-	-	Falta disuria, cambios en aspecto de orina y secreción uretral, dado que son los datos guía del cuadro clínico (orquiepididimitis). No son datos de valor astenia y adinamia, acompañantes del síndrome

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
51	16/01/2026 12:28	partial	-	-	-	No es necesario siempre describir todos los síntomas, se puede hacer un agrupamiento sindrómico que es más facil de leer e interpretar. Por ejemplo: foco neurológico - caída de comisura labial derecha
52	16/01/2026 04:39	ok	-	-	-	-
53	16/01/2026 04:12	ok	-	-	-	-
54	15/01/2026 14:33	partial	-	-	-	en dos oportunidades no aporta valor ni es un dato claramente constatable
55	15/01/2026 13:46	ok	-	-	-	-
56	15/01/2026 13:36	ok	-	-	-	-

Comentarios Textuales Destacados (34 con texto):

1. [PARTIAL] - 28/01/2026 16:09 > Solamente correposnde debilidad de miembros inferiores

2. [BAD] - 28/01/2026 01:21 > Corresponde que diga "Neurocirugía programada: resección de recidiva de glioma de alto grado parietal derecho". El resto no corresponde aclarar. No se debe escribir todo en mayúsculas

3. [PARTIAL] - 27/01/2026 21:30 > Retención aguda de orina es un diagnostico medico, el paciente consulta pro hematuria como se especifico y ademas polaquiuria y tenesmo vesical.

4. [BAD] - 27/01/2026 03:15 > El paciente ingresa directamente a UCI. La epicrisis de alta calidad debe dar una idea clara de la gravedad del cuadro. En este caso el resumen de ingreso es sepsis a foco de piel y partes blandas a punto de partida de miembros inferiores. Resume y detalla el cuadro y el punto de partida

5. [BAD] - 26/01/2026 17:34 > Frenulotomia programada deberia decir

6. [BAD] - 26/01/2026 14:07 > El motivo de internación es la ablación programada. el resto es una complicación del procedimiento.

7. [BAD] - 24/01/2026 14:35 > Muy largo. Con "cirugía programada" o "Cirugía por recidiva de glioma de alto grado" es suficiente.

8. [PARTIAL] - 23/01/2026 23:31 > Solo se debe describir lo que motivó a la internación del paciente. En este caso resección neuroquirúrgica programada de recidiva de glioblastoma cerebral

9. [PARTIAL] - 23/01/2026 12:34 > Aquí el motivo de internación es cirugía programada. Siempre que se trate de un paciente que ingresa para un procedimiento quirúrgico se debe aclarar "cirugía programada de (lo que corresponda)"

10. [PARTIAL] - 23/01/2026 12:19 > Le falta agregar que tuvo dorsalgia y fiebre. Si bien no está en el ingreso, lo agrega en evoluciones posteriores y es importante para el cuadro clínico actual

11. [**PARTIAL**] **- 22/01/2026 21:38** > Generalmente no se aclara mucho en el motivo de internación se pone el motivo que lo motivo a consultar principalmente o internarse. La aclaración de cirugía reciente corresponde a la evolución

12. [**PARTIAL**] **- 22/01/2026 20:36** > Muchas veces se aclara que es una cirugía programada ya que no es lo mismo que sea programada que sea de urgencia. De todos modos no esta mal el motivo de internación.

13. [**PARTIAL**] **- 20/01/2026 21:46** > No corresponde en esta sección que es traída desde geriátrico

14. [**PARTIAL**] **- 20/01/2026 18:39** > En este caso la internación fue programada para la resección del tumor de la glándula pineal. La hidrocefalia y compromiso del tercer ventrículo es un antecedente, que previamente motivó la colocación de válvula de derivación ventriculo-peritoneal, y esto es imprescindible para entender la historia

15. [**BAD**] **- 20/01/2026 14:25** > diarrea cronica, dolor anal y fiebre. La presencia de fiebre en las ultimas 48hs cambia el cuadro

16. [**BAD**] **- 20/01/2026 02:15** > inestabilidad a la bipedestación, dificultad para deglutir y alteración de la sensibilidad de 2 años de evolución.

17. [**BAD**] **- 20/01/2026 01:38** > Lumbalgia invalidante. El pop no es el motivo de internación. Se interna y se define indicación quirúrgica

18. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 22:49** > Se debe incluir los síntomas que motivaron la internación, en este caso la disnea (dato más importante porque se relaciona con el diagnóstico posterior), y asociado la astenia, adinamia y deposiciones diarreicas (datos secundarios)

19. [**BAD**] **- 19/01/2026 14:57** > Tiene varios antecedentes de importancia. No categorizar uno solo. Viene por Falta de aire y mareos.

Es importante no sesgarse y atenerse al motivo de consutla si decidimos ese formato de epicrisis o al motivo de internación si decidimos otro modelo.

20. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 00:53** > El motivo de internación debe ser lo más simple y técnico posible para permitir interpretación correcta sin ambiguedades. En este caso deterioro del sensorio y hematuria sería correcto. Si se quiere hacer mención a que la paciente tiene un deterioro cognitivo previo y que actualmente hay un empeoramiento/progresión del mismo, debe hacerse mención explícita.

21. [**BAD**] **- 17/01/2026 15:44** > Dolor abdominal y vómitos, mas corto y sin tanta explicación. El diagnóstico es posterior.

22. [**BAD**] **- 17/01/2026 15:42** > Dolor abdominal y vómitos

23. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 15:14** > Disuria, polaquiuria y movimientos anormales.

24. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 14:40** > Solamente: disnea o disnea + deterioro del estado general

25. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 14:14** > Solamente "Melena"

26. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 13:36** > El motivo de internación es el síntoma de la paciente, el diagnóstico de ACV se hace posteriormente. El motivo de internación tiene que se corto y claro. No abreviar, en vez de TEC poner traumatismo encefalocraneano

27. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 13:14** > Se debe tecnificar el lenguaje para evitar malinterpretaciones. En este caso se podría consignar: retención aguda de orina u oliguria y deterioro del sensorio

28. [**BAD**] **- 17/01/2026 12:43** > Siempre describir síntomas, signos o síndrome que motiva la internación. No se debe hacer un diagnóstico etiológico si no existe seguridad al respecto. En este caso el motivo de internación fue dolor abdominal y diarrea en paciente con eventroplastia reciente. Se podría agregar la presencia de una colección subcutánea abdominal en estudio.

29. [**PARTIAL**] **- 16/01/2026 23:36** > Aquí corresponde consignar síndrome febril (dado que incluye las otras manifestaciones como astenia, anorexia, decaimiendo que acompañanan ala fiebre) prolongado (dado que tiene 1 mes de evolución) de origen incierto, asociado a nauseas. No conviene jerarquizar aquí las neoplasias vesicales y parotídeas porque es un dato que no queda clarificado respecto a certeza diagnostica, estadio y tratamiento

30. [**BAD**] **- 16/01/2026 18:11** > Inespecifico no. Aporta a la confusión o a un interrogatorio pobre mas que a información util

31. [PARTIAL] - 16/01/2026 13:46 > No queda clara la perforación intestinal (no se evidencia en laparascopia exploradora). Se podría reducir a dolor abdominal y proctorragia secundaria a traumatismo anal autoinflingido

32. [PARTIAL] - 16/01/2026 12:56 > Falta disuria, cambios en aspecto de orina y secreción uretral, dado que son los datos guía del cuadro clínico (orquiepididimitis). No son datos de valor astenia y adinamia, acompañantes del síndrome

33. [PARTIAL] - 16/01/2026 12:28 > No es necesario siempre describir todos los síntomas, se puede hacer un agrupamiento sindrómico que es más facil de leer e interpretar. Por ejemplo: foco neurológico - caída de comisura labial derecha, hemidisesestesias homolaterales y disartria

34. [PARTIAL] - 15/01/2026 14:33 > en dos oportunidades no aporta valor ni es un dato claramente constatable

---

Evolución

Estadísticas: - Total: 47 evaluaciones - OK: 3 | Parcial: 21 | Malo: 23 - Omisiones: 18 | Repeticiones: 4 | Confuso: 14

Feedbacks Individuales (47 registros):

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
1	28/01/2026 16:20	partial	Sí	-	-	En antecedentes falta aclarar que es monorrena por reseccion de tumor. Por otro lado ella ingresa por debilidad progresiva de miembros inferiores ascendente no por la ITU como dice ahi. La infección
2	28/01/2026 01:42	bad	Sí	-	Sí	• Mal redactados los antecedentes. Sería correcto: "Paciente de 62 años que presenta antecedentes de glioma de alto grado parietal derecho, que presentó como complicación infección de sitio quirúrgico

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
3	27/01/2026 21:38	bad	Sí	-	Sí	Es un resumen muy confuso del paciente. Hay que aclarar mejor la interpretacion del medico y porque pide determinados estudios y decide hacer dichos tratamientos. Se entiende mejor cuando la evaluac
4	27/01/2026 21:00	bad	Sí	Sí	Sí	• Están bien descriptos los antecedentes patológicos. No se menciona la medicación habitual. • Mejorar redacción acerca del motivo de ingreso: debería decir "internación reciente del 1/12/23 al 7/12/
5	27/01/2026 14:24	bad	Sí	-	Sí	No sigue el orden cronológico de los hechos. Ingresa febril interpretandose como NIH. Evoluciona con deterioro de la funcion renal y signos de flogosis en herida quirurgica. se realiza eco que observa
6	27/01/2026 13:22	partial	Sí	-	Sí	En líneas generales es correcto el contenido pero esta desorganizado. Con respecto a los antecedentes personales falta el antecedente de anemia crónica secundaria a hematuria con requerimiento de múlt

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
7	27/01/2026 03:30	bad	Sí	-	Sí	Paciente ingresa en shock septico directamente a Unidad cerrada donde permanece 8 días sin ARM ni inotropicos. Eso debe constar el tiempo en unidad cerrada. Es importante que diga que antibioticos rec
8	26/01/2026 17:35	partial	-	-	Sí	Se decide egreso y control por consultorios externos
9	26/01/2026 16:05	bad	Sí	-	Sí	Shock septico es a foco de piel y partes blandas. Es importante poner el foco. Antes que el shock septico evoluciona primero con sme confusional y fiebre. Es importante cuantos días de ARM y de inotr
10	24/01/2026 14:43	partial	Sí	Sí	-	Faltan datos por ejemplo: estuvo intubado por deterioro del sensorio entonces es importante aclarar cuantos dias, en este caso fueron 10. Con weaning dificultoso pero con psoterior extubación exitosa

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
11	23/01/2026 23:43	partial	Sí	Sí	Sí	El primer párrafo es correcto. Los errores más importante son por omisiones. Está correctamente aclarada la cirugía que se realizó pero en cuanto a las complicaciones: -Hipertension severa: se tiene
12	23/01/2026 21:25	partial	-	Sí	-	Omitiría "orientado en tiempo y espacio y hemodinámica-mente estable". Para decir que está lúcido, falta que diga que está orientado en persona también, y especificarlo es redundante. Se puede decir "P
13	23/01/2026 13:08	bad	Sí	-	Sí	El primer párrafo está correcto. Falta aclarar que al ingreso se toman hemocultivos (el resultado fue 1/2 staphylococcus coagulasa negativo que se intrepretó como contaminante, pero es necesario aclar
14	23/01/2026 12:27	bad	Sí	-	Sí	Existen errores y omisiones en el relato del cuadro. En primer lugar el paciente presenta paraplejía y un nivel sensitivo D8-9 (si bien no está al ingreso, está muy bien descripto por el neurocirujano

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
15	22/01/2026 21:54	bad	Sí	-	Sí	Al intentar resumir se torna muy confuso. Lo ideal es tratar de contar de manera cronológica lo que le sucedió al paciente e ir aclarando lo que fue interpretando el médico diviendo por sistemas para
16	22/01/2026 20:39	ok	-	-	-	-
17	21/01/2026 12:15	ok	-	-	-	-
18	20/01/2026 22:28	bad	Sí	-	-	• Cabe mencionar que la caída fue en la vía pública, que fue una caída de propia altura sentada y sin TEC (éste último dato muy importante), y que ingresó a Emergencias en ambulancia • No se consigna
19	20/01/2026 21:50	bad	Sí	-	Sí	• Bien colocados los antecedentes • No esta consignada su medicación habitual en ninguna parte de la epicrisis • "Ingresa por cuadro de 1 semana de evolución de excitación psicomotriz y negativismo a

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
20	20/01/2026 21:19	bad	Sí	-	-	• Mejorar redacción: “Paciente femenina de 18 años con antecedente de exéresis de Xantoastrocitoma Pleomorfico en 2019 en Hospital Garrahan, que requirió quimioterapia psoteriormente por dos años (se
21	20/01/2026 20:00	bad	Sí	-	-	1. Incompleta la parte de los antecedentes patológicos. Se mencionan en diferentes evoluciones clínicas. Para que quede completo, los antecedentes patológicos de esta paciente son los siguientes: HTA,
22	20/01/2026 18:48	partial	Sí	-	Sí	La redacción está bien pero tiene omisiones y errores en el relato. Cuando tiene el episodio de clonus se inicia levetiracetam pero cuando posteriormente presenta el deterioro del sensorio (que fue se

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
23	20/01/2026 02:55	bad	-	-	-	Falta el antecedente de IRC con Cr. basal de 3. Al ingreso presenta ademas del derrame pleural probnp de 1000. Este dato es relevante para este diagnóstico. El balance negativo fue violento por 4 d
24	20/01/2026 02:25	bad	-	-	-	dice que se solicito ic con cardiología pero no esta la evaluación cardiologica que descarta toxicidad. Esto fue previo a los pulsos de corticoides. Es importante respetar el orden cronológico de ocu
25	20/01/2026 01:52	partial	-	-	-	si bien es verdad que la paciente estuvo varios días esperando el procedimiento, puede detallarse mas la sucesión de estudios y el tratamiento analgesico. Por ejemplo puede expresarse. Se inicia trata
26	19/01/2026 23:05	partial	-	-	-	En cuanto a los antecedentes faltan dos de mucha jerarquía para el cuadro actual: -La realización de limpieza y liberación de la válvula mitral protésica en enero por pannus. -La consulta previa por l

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
27	19/01/2026 15:07	bad	-	-	-	ERC (Seguimiento por nefrología) esto no aporta valor a la epicrisis. Si aporta valor cual es la creatinina basal conocida. Al mismo tiempo se sabe que es monoreno funcional En un paciente con ERC es
28	19/01/2026 13:24	bad	-	-	-	1. No se aclaran los antecedentes patológicos de la paciente (HTA, marcapasos, diabetes, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, RTC bilateral, deterioro cognitivo crónico, insuficiencia venosa). Si
29	19/01/2026 01:10	partial	-	-	-	Los antecedentes personales tienen que organizarse y agruparse, y ser lo más claros posibles, declarando tambien los aspectos que no se conocen. En este caso el deterioro cognitivo severo es la CAUSA
30	19/01/2026 00:38	partial	-	-	-	Es importante que todos los antecedentes relevantes para la enfermedad actual estén especificados con el máximo detalle, como en este caso la trombocitosis. A su vez siempre revisar todas las evolucio

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
31	19/01/2026 00:26	partial	-	-	-	Es importante describir con mayor profundidad los antecedentes que tienen relación con el cuadro actual, como en este caso la trombocitosis. Recordar que los mismos pueden ir surgiendo en el relato de
32	18/01/2026 17:23	ok	-	-	-	-
33	17/01/2026 15:49	partial	-	-	-	Falta aclarar en antecedentes que la obstrucción fue secundaria a bridas por apendicetomía previa. Aclarar que el antibiótico lo recibió únicamente por 24hs y luego se suspendió. Aclarar que tuvo so
34	17/01/2026 15:22	bad	-	-	-	Falta aclarar antecedentes personales: polineuropatía diabética, glaucoma, hipoacusia y el más importante es que tuvo un procedimiento días previos el 17/12 (una ureteroscopía). Todo esto es important

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
35	17/01/2026 14:45	partial	-	-	-	Esta muy resumido y no se entiende que interpreto el médico. Al desglosarlo por sistemas es más simple entender que estudios se pidieron y por qué. Ej: en un inicio se sospechó infección de piel y pa
36	17/01/2026 14:16	partial	-	-	-	Faltan antecedentes (están incompletos) y medicación habitual.
37	17/01/2026 13:46	bad	-	-	-	1) Faltan antecedentes: SCASEST (significa sidnrome oronario gudo sin elevación del st= + EAp edema agudo de pulmón, agregar quela colocación e marcapasos s por bloqueo AV de alto grado, Insuficiencia
38	17/01/2026 13:39	partial	-	-	-	Dentro de los antecedentes es importante también las consultas previas en relación a la enfermedad actual, por ejemplo en este caso hace 48 horas presentó retención aguda de orina, se realizó sondaje

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
39	17/01/2026 12:51	partial	-	-	-	Está correcta la priorización de antecedentes relevantes, en este caso el antecedente quirúrgico reciente. En este caso se debe ser lo más preciso posible en su descripción dado que tiene relación con
40	16/01/2026 23:43	partial	-	-	-	En este caso corresponde clarificar un poco mejor los antecedentes, dado que son muy relevantes para el cuadro clínico. Tener en cuenta que los antecedentes se van construyendo durante la historia clí
41	16/01/2026 18:17	bad	-	-	-	Debe colocarse el antecendente de cirugía reciente (15 días antes de la internación) La secuencia temporal es importante para entender el diagnóstico. Falta el drenaje del seroma Que infectología re
42	16/01/2026 13:51	partial	-	-	-	Está bien aclarado en la primera TAC que sugiere perforación, pero debería explicitarse el informe de la segunda TAC (con contraste) que no evidencia pase de la sustancia de contraste a peritoneo (per

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
43	16/01/2026 13:04	partial	-	-	-	En radioterapia “antigua” conviene no utilizar calificativos y ser lo más preciso posible (año aproximado), y aclarar por qué se realizó la misma (en este caso sin diagnostico claro), dado que permite
44	16/01/2026 12:32	partial	-	-	-	Es muy importante consignar el tiempo de evolución del cuadro, sobretodo en focos neurológicos. Si es incierto como en este caso, hay que especificarlo. La TAC informaba edema peri-sangrado leve, en e
45	16/01/2026 04:41	bad	-	-	-	La redacción es poco clara. Recomiendo seguir un algoritmo de Antecedentes y medicación habitual, para luego detallar el motivo de consulta y resumen de la internación. Internación reciente debe acla
46	16/01/2026 04:25	bad	-	-	-	Se interpreto como HDA variceal (no se diagnosticó). -Es importante diferenciar lo que es probable de lo que esta confirmado. en este caso no se confirmo que el sangrado sea variceal. IC con hepatol

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
47	15/01/2026 13:50	bad	-	-	-	-No colocaría consumo de alcohol. -El antecedente de Alcoholismo, salvo que sea un paciente con patología por alcohol declarada expone a riesgos legales dado que no es un antecedente constatable y pue

Comentarios Textuales Destacados (44 con texto):

1. [PARTIAL] - 28/01/2026 16:20 > En antecedentes falta aclarar que es monorrena por reseccion de tumor. Por otro lado ella ingresa por debilidad progresiva de miembros inferiores ascendente no por la ITU como dice ahi. La infección urinaria ya estaba en tratamiento previamente y es un antecedente importante de mencionar pero que no motiva a consultar o internarla. Es importante aclarar los valores de una punción de liquido cefalorraquideo es insuficiente colocar unicamente "líquido cristalino y presión normal". Es importante aclarar TODO lo que se solicito en sangre y LCR no se puede poner "serologías virales, pcr tbc, etc" Falta aclarar que tuvo FAN positivo, que infectología indico vacunación al egreso. Es importante aclarar que se deriva a centro de tercer nivel y que le queda pendiente continuar con rituximab

2. [BAD] - 28/01/2026 01:42 > • Mal redactados los antecedentes. Sería correcto: "Paciente de 62 años que presenta antecedentes de glioma de alto grado parietal derecho, que presentó como complicación infección de sitio quirúrgico y se le realizó toilette, y recibió tratamiento con temozolamida y radioterapia. Presenta recidiva tumoral, por lo que se decidió internación programada para resección quirúrgica" • Corresponde redactar en tiempo pasado, por ejemplo "Ingresó a UTI en postoperatorio inmediato…" • No se detallan ni describen complicaciones importantes que el paciente presentó en el postoperatorio. Correspondería describir la evolucion de la siguiente forma, por aspectos: "Cursó internación prolongada en UCI, donde evolucionó, según aspectos: - Neurológico: presentó convulsiones tónico clónicas generalizadas en el postoperatorio inmediato, se realizó TC de cerebro sin hallazgos agudos. Foco neurológico motor con paresia braquial izquierda y plejía crural izquierda. Presentó movimientos involuntarios, que fueron estudiados en conjunto con Neurología, con EEG repetidos. No se halló actividad paroxística, se manejaron los mismos con levetiracetam + fenitoína y lacosamida. Presentó en múltiples oportunidades episodios de excitación psicomotriz, llegando a requerir sedación profunda y IOT/ARM desde el 26/2 al 1/3. El 17/3 en control por Neurocirugía se evidenció salida de liquido seroso por herida quirúrgica, interpretándose como fístula de líquido cefalorraquídeo. Se realizó punto de sutura y cierre de la herida local. Por fiebre, mioclonías y episodios de excitación psicomotriz, se decidió colocación de drenaje lumbar externo por fístula de LCR persistente. - Hemodinámico/cardiovascular: tendencia a la hipertensión arterial, manejada con infusión continua de nitroprusiato de sodio, que luego se tituló a antihipertensivos vía oral - Hematológico: plaquetopenia interpretada de causa multifactorial (sepsis, fármacos anticomiciales, consumo, etcétera) recibió múltiples transfusiones. - Infectológico: múltiples episodios febriles, presentó como intercurrencias infectológicas neumonía aspirativa con rescate de K. pneumoniae sensible en aspirado traqueal, cumplió tratamiento antibiótico con AMS. Luego presentó UC con rescate el 15/3 de K. pneumoniae, también realizó tratamiento con AMS. Posteriormente presentó como complicación más importante, meningitis postquirúrgica tardía, en relación a drenaje lumbar externo. Recibió tratamiento empírico con meropenem + vancomicina + colistin. El paciente evolucionó tórpidamente, con persistencia febril y deterioro del estado neurológico, se decidió en acuerdo con familiares en contexto de recidiva de glioma de alto grado y múltiples complicaciones, limitación de los esfuerzos terapéuticos. Falleció el 2/4 a las 17hs." • Evolucionar por aspectos (infectológico, neurológico, etc) es la mejor forma de describir la evolución de un paciente complejo con múltiples intercurrencias, de manera resumida y sin omitir información

3. [BAD] - 27/01/2026 21:38 > Es un resumen muy confuso del paciente. Hay que aclarar mejor la interpretacion del medico y porque pide determinados estudios y decide hacer dichos tratamientos. Se entiende mejor cuando la

evaluación se desglosa por especialidad. ej: 1) Infectológico: aclarar todos los rescates microbiológicos y aclarar cual fue el tratamiento final que se realizo. Por otro lado aclarar que por infección a repetición se realizo retiro de cateter doble JJ y se planteo nefrectomia. 2) Nefrologico: por insuficiencia renal cronica con infecciones a repeticion se plantea la posibilidad de transplante renal en plan de derivarlo a favaloro. 3) Hematologico: presento por anemia cronica requerimiento transfusionales. En rmn de abdomen realizada por infecciones a repeticion se constata trombosis de vena renal que por alto riesgo de sangrado hematologia decide iniciar bomba de infusión continua de heparina controlada en unidad coronaria.

Evoluciona con PCR se realiza maniobras de RCP, administracion de noradrenalina y atropina, se constata taquicardia auricular bloqueada y luego BAV completo, se coloca marcapasos transitorio externo e isoproterenol sin resultados positivo, se descarta con ecografia en lecho taponamiento cardiaco, con sospecha presuntiva de tromboembolismo de pulmon con RCP frustra y obito

4. [BAD] - 27/01/2026 21:00 > • Están bien descriptos los antecedentes patológicos. No se menciona la medicación habitual. • Mejorar redacción acerca del motivo de ingreso: debería decir "internación reciente del 1/12/23 al 7/12/23 por reemplazo parcial de cadera derecha, que intercurre con registros febriles en domicilio y es derivado a Emergencias en amblancia" • "Se realizó TAC de tórax que evidenció infiltrados bilaterales y derrame pleural leve a predominio izquierdo, interpretado como neumonía intrahospitalaria. Se tomaron hemocultivos y se inició tratamiento antibiótico empírico con Piperacilina/Tazobactam." Correcta descripción de la interpretación inicial del caso. Luego cabería aclarar "Se decidió internación en sala general, donde se evidenció edema e induración en herida quirúrgica, se realizó ecografía evidenciandose colección hiperecogénica. Se reinterpretó cuadro como infección peri-protésica temprana o precoz." A partir de alli, se debe describir el caso por aspectos, de la siguiente forma: - Traumatológico: se realizó el 13/12 punción guiada por ecografía de colección por equipo de Traumatología y se remitió a cultivo. El 15/12 se realizó toilette quirúrgica evidenciando abundante hematoma infectado, que también fue remitido a cultivo. Presentó luego sangrados por herida quirúrgica, el 26/12 se realizó drenaje en la habitación y el 3/1 se colocó VAC. - Infectológico: se agregó a esquema antibiótico de Piperacilina/Tazobactam, vancomicina. Presentó falla renal asociado al uso de vancomicina, rotandose éste a linezolid. Se obtuvo aislamiento en 1 de 2 hemocultivos de ingreso de SCN, interpretado como contaminante. No se obtuvo aislamientos bacteriológicos de punción de colección ni de toilette quirúrgicas (ambas realizadas intra antibiótico). El 24/12 se rotó antibioticoterapia a vía oral, esquema levofloxacina + minociclina, a continuar luego del egreso hospitalario. - Hematológico: presentó descenso de hemoglobina, que requirió varias transfusiones a lo largo de la internación, y también plaquetopenia, interpretada por consumo versus freno medular por sepsis. Se indicó y solicito internación domiciliaria con heparina sódica como profilaxis de TVP. - Cardiovascular: presentó episodios de desaturación, con signos de sobrecarga hídrica, sin signos de falla aguda de bomba. Fue evaluado por Cardiología, realizó balance negativo hasta cese de requerimiento de oxigenoterapia suplementaria. Ante buena evolución clínica, afebril, sin nuevos rescates microbiológicos y VAC funcionante, se otorgó egreso sanatorial con internación domiciliaria y se indicó seguimiento ambulatorio con especialistas. • Es incorrecto "se decidió continuar tratamiento antibiótico EV hasta completar esquema." Se cumplieron 2 semanas iniciales de tratamiento endovenoso, luego se rotó a vía oral.

5. [BAD] - 27/01/2026 14:24 > No sigue el orden cronológico de los hechos. Ingresa febril interpretandose como NIH. Evoluciona con deterioro de la funcion renal y signos de flogosis en herida quirurgica. se realiza eco que observa colección. Se punza por aguja fina y se decide toilette. se realiza toilette quirurgia (es importante la fecha) y luego se coloca vac. Los cultivos de herida resultan negativos pero fueron tomados intraantibioticos. es importante colocarlo. Se rota tratamiento a via oral y se coloca VAC en herida. es importante seguir el orden cronologico y congruente de los hechos

6. [PARTIAL] - 27/01/2026 13:22 > En líneas generales es correcto el contenido pero esta desorganizado. Con respecto a los antecedentes personales falta el antecedente de anemia crónica secundaria a hematuria con requerimiento de múltiples transfusiones (es importante porque despues presenta incompatibilidad de las unidades que se transfunden) e infecciones urinarias a gérmenes BLEE. Es correcto que se cambia de PTZ a imipenem pero esto es justamente por el antecedente de infecciones a gérmenes BLEE. Luego por persistir febril primero se recambian los catéteres doble J y se realiza litotricia derecha, y luego con los aislamientos microbiológicos en urocultivo (Klebsiella) y catéteres (SAMR+Proteus) se rota esquema antibiótico a TMS y ciprofloxacina. Aquí es fundamental el orden de los acontecimientos para entender el cuadro. Luego ante la persistencia de la fiebre se recambia la sonda vesical y en ese urocultivo crece una levadura por lo que se agrega fluconazol. Se decide vincular a hemodiálisis por catéter yugular (esto debe estar en la historia clínica) y se retiran los catéteres doble J urinarios. En dichos catéteres se desarrolla un germen BLEE pero con sensibilidad a TMS por lo que sigue el mismo esquema. Por último es correcto que se realiza una RMI que evidencia trombosis de la vena renal izquierda por lo que inicia anticoagulación con BIC de heparina (esto debe estar aclarado en la epicrisis). Además se debe dejar claro el motivo de óbito, en este caso

presuntivamente fue un tromboembolismo de pulmón masivo

7. [BAD] - 27/01/2026 03:30 > Paciente ingresa en shock septico directamente a Unidad cerrada donde permanece 8 días sin ARM ni inotropicos. Eso debe constar el tiempo en unidad cerrada. Es importante que diga que antibioticos recibió y por cuanto tiempo fue el esquema Realizo una FA ARV que no respondió a b bloqueantes + digocina por lo que se inició amiodarona. Hizo como consecuencia un IAM tipo II por lo que se realizo una ccg en la cual se intervino con stent farmacologico a la CX y se objetivo lesion distal en DA. es importante describir la anatomia coronaria y la intervencion completa. Es evaluado por electrofisiología por sme taqui bradi quien reevaluara en 3 meses de doble antiagregación colocación de marcapasos. Paciente queda con Doble antiagregación por stent + anticoagulación por FA. Evolucióna con caida de 14 puntos del hto. Se realiza VEDA sin signos de sangrado y dos VCC con preparación defectuosa, sin objetivar sangrado. Se decide no restaurar Anticoagulación dado el riesgo. Evoluciona estable y con hto en ascenso. Se decide alta con Internación domiciliaria

8. [PARTIAL] - 26/01/2026 17:35 > Se decide egreso y control por consultorios externos

9. [BAD] - 26/01/2026 16:05 > Shock septico es a foco de piel y partes blandas. Es importante poner el foco. Antes que el shock septico evoluciona primero con sme confusional y fiebre. Es importante cuantos días de ARM y de inotropicos necesitó, sumado a que inotropicos utilizo (en este caso requirió ARM por 6 días y noradrenalina por 8 días) Lesiones en mejoría con tto atb realiza toilette por plástica, esto fue antes que planear arteriografía. es bueno no ponerlo cronologicamente al mismo tiempo. Es importante colocar que la flia se comunica el mal pronostico (no poner pronostico ominoso) y que se consensua no progresar con nuevas maniobras invasivas priorizando la calidad de vida. Fallece no: El 29/7 presenta PCR declarandose obito a las 22hs.

10. [PARTIAL] - 24/01/2026 14:43 > Faltan datos por ejemplo: estuvo intubado por deterioro del sensorio entonces es importante aclarar cuantos dias, en este caso fueron 10. Con weaning dificultoso pero con psoterior extubación exitosa y posterior prueba de deglución ok (importante tambien en personas que estuvieron intubadas) Me parece importante aclarar que evoluciono torpidamente con varios episodios de excitación psicomotriz de dificil manejo y movimientos anormales que fueron evaluados por neurologia y tratados. Por ultimo poner que tuvo una complicación de la cirugia programada que fue la fistula de LCR con rescate de bacilo gram negativo en lcr de drenaje lumbar interpretado como meningitis postquirurgica y que ahi los familiares deciden limitar maniobras invasivas priorizando confort (importante aclarar lo hablado con la familia en paciente que no tienen poder de decidir sobre si mismos). Finalmente aclarar que por mala evolución y lo hablado con la familiar se prioriza confort y fallece. Aclarar día y horario de fallecimiento.

11. [PARTIAL] - 23/01/2026 23:43 > El primer párrafo es correcto. Los errores más importante son por omisiones. Está correctamente aclarada la cirugía que se realizó pero en cuanto a las complicaciones: -Hipertension severa: se tiene que explicitar las drogas antihipertensivas que se utilizaron. -Convulsiones: se debe aclarar que se repitieron EEG en varias oportunidades y qué farmacos realizó, en este caso levetiracetam, fenitoina y fenobarbital. -Sindrome confusional: falta la interpretación (dice excitación psicomotriz). Esta fue una de las complicaciones mas importantes dado el manejo dificultoso y la causalidad que puede tener con el resto de complicaciones. Realizó múltiples drogas importantes: quetiapina, haloperidol, dexmedetomidina. -La neumonía fue la primera complicación y posterior a esto se realizó intubación (no fue una neumonia asociada a ventilación). Se debe explicitar que completó antibióticos con ampicilina-sulbactam por aislamiento de gérmen sensible en aspirado traqueal. Faltan las siguientes complicacioens: -Infección urinaria: a una Klebsiella sensible por lo que completó tratamiento con ampicilina-sulbactam. -Temblores interpetados secundarios a piramidalismo, por lo que realizó baclofeno. -Ileo que requirió colocación de sonda rectal. -Fístula de LCR: esta es la complicación cardinal y que determinó el desenlace. Se realizó primero sutura y luego colocación de drenaje lumbar que el paciente se retiró. -Meningitis post neuroquirúrgica: con aislamiento de bacilo gram negativo, realizó vancomicina, meropenem y colistin. Debe aclararse que se limitaron esfuerzos terapéuticos y el paciente obitó.

12. [PARTIAL] - 23/01/2026 21:25 > Omitiría "orientado en tiempo y espacio y hemodinámicamente estable". Para decir que está lúcido, falta que diga que está orientado en persona también, y especificarlo es redundante. Se puede decir "Paciente lúcido y hemodinámicamente estable, sin complicaciones en el postoperatorio inmediato".

13. [BAD] - 23/01/2026 13:08 > El primer párrafo está correcto. Falta aclarar que al ingreso se toman hemocultivos (el resultado fue 1/2 staphylococcus coagulasa negativo que se intrepretó como contaminante, pero es necesario aclararlo) y se inicia transitoriamente vancomicina (por sospecha de infección de herida quirúrgica). Intercurre con insuficiencia renal aguda (se interpreta de etiología prerrenal), se suspenden nefrotóxicos entre ellos vancomicina y se rota a linezolid. Es fundamental en cuadros infectológicos dejar explicitado los antibióticos que se realizaron con sus días totales (o fechas de inicio y fin). Luego el hallazgo más importante lo da la ecografía de

partes blandas que informa una colección subcutánea (esto es de gran valor en un cuadro febril con antecedente quirúrgico reciente) que inicialmente se realiza punción y luego toilette con drenaje de hematoma con sospecha de infección (esto es el 15/03 y debe siempre aclararse la fecha). Deben estar incluidos los resultados de todos los cultivos. Luego de esto completa 7 días efectivos (se cuenta efectivo posterior al drenaje) de linezolid y piperacilina-tazobactam luego rotándose a antibiótico via oral con levofloxacina/minociclina. Es un error explicitar que se va con tratamiento endovenoso, dado que se rotó a vía oral 7 días antes del alta. Además hay que aclarar el motivo de persistencia de internación en la última semana que fue la presencia de abundante débito hemático por la herida, lo cual es imprescindible para la evolución. Y aquí es donde se asocia a anemia y plaquetopenia, que es evaluada por hematología que la interpreta en contexto de cuadro inflamatorio/infeccioso. Traumatología desestima realizar nueva toilette y solicita sistema de vacío continuo. Es fundamental seguir la cronología correcta de los hechos, ordenando la interpretación diagnóstica (diagnóstico presuntivo etiológico/definitivo), los estudios realizados, la gravedad del cuadro y el tratamiento instaurado. Luego también explicitar cronologicamente las intervenciones y complicaciones. En cuadros infecciosos no se pueden omitir cultivos y días de antibióticos.

14. [BAD] - 23/01/2026 12:27 > Existen errores y omisiones en el relato del cuadro. En primer lugar el paciente presenta paraplejía y un nivel sensitivo D8-9 (si bien no está al ingreso, está muy bien descripto por el neurocirujano y desde allí lo refieren igual, con leve mejoría hacia el final de internación). Con respecto al tratamiento, si bien al inicio se plantea el inicio de aciclovir e inmunoglobulina por las características del líquido cefalo-raquideo (principalmente la hiperproteinorraquia) rapidamente se desestima, no se realiza, y al obtener rescate de Staphylococcus en hemocultivos no se indica. Es importante destacar que los hallazgos de la TAC se confirman con RMI que evidencia espondilodiscitis, y lesión isquémica medular por compresión, por lo que se inician corticoides. Además una omisión muy grave es el ETE, que evidencia imágenes filiformes en válvula aortica, que en este contexto se interpretan como endocarditis infecciosas. Ademas se realizó una TAC de torax, abdomen y pelvis, que descarta embolias, esto no debe pasarse por alto dado que cambia el tratamiento del cuadro. Se termina interpretando como una endocarditis infecciosa a Staphylococcus aureus meticilino sensible asociada a espondilodiscitis D7-8, y se inicia antibiótico con cefepime. Se debe destacar que cerca de la finalización del mismo el paciente intercurre con dolor invalidante, se repite la RMI que evidencia progresión imagenológica, y se realiza artrodesis, disectomía y drenaje de material purulento. Esto determina que se cumplan +42 días de cefepime (posterior a negativización de hemocultivos) y deba continuar con levofloxacina/rifampicina como tratamiento de una osteomielitis. En ningun lugar se aclarar el gérmen aislado, esto no puede faltar, así como los días de antibióticos

15. [BAD] - 22/01/2026 21:54 > Al intentar resumir se torna muy confuso. Lo ideal es tratar de contar de manera cronológica lo que le sucedió al paciente e ir aclarando lo que fue interpretando el médico diviendo por sistemas para que se interprete todo de la mejor manera. ej: 1) infectológico/traumatologico: a su ingreso se realizo tac de torax con evidencia de infiltrados por lo que inició el 9/12 piperacilina tazobactam. Se obtuvo en hemocultivo rescate de bacilo gram negativo (es importante aclarar los rescates de los cultivos) que se interpreto como contaminante. Ademas se agrega linezolid para cubrir foco quirurgico reciente. Durante la internación presento diarrea liquida se solicita toxina para clostridium difficile que fue negativa y se trata con bismuto. Por secreción de la herida abundante y ecografia que constato colección se realiza inicialmente puncion biopsia en lecho por piel sana el 13/12 y luego el 15/12 toilette con muestras negativas. Se realizo tratamiento endovenoso hasta 22/12 inclusive luego vo con levofloxacina + minociclina (se rota a vo el 24/12). Es importante aclarar fechas para que sepamos cuantos dias recibio tratamiento endovenoso y como respondio a ello el paciente. Por útlimo aclarar que se coloca un sistema de aspiración continua para evitar nueva conducta invasiva en contexto de paciente fragil y riesgo alto ante nueva intervención.

2) cardiologico: importante aclarar que evolucionó con insuficiencia cardiaca que necesito balance negativo con furosemida y requerimiento de oxigenoterapia a bajo flujo.

3) hematologico: falta aclarar que se transfundió en oportunidades pro descenso de hematocrito y que se interprete plaquetopenia pro sepsis. Indicando tromboprofilaxis on heparina sodica e tratamiento con eritropoyetina semanal.

4) respiratorio: aclarar que se sospecho tromboebolismo e pulmon y que se realizo doppler y angiotomografía. Es importante aclararlo porque mas alla de la tópida evolución del paciente por ejemplo en este caso apra la angiotomografia recivio contraste endovenoso ue es toxico para el riñon y el paciente tenia insuficiencia renal.

otro detalle importante aclarar la presencia de la escara, porque es parte del examen fisico y corresponde para dejar en claro que no tiene tratamiento l momento quirurgico y que se hace tratamiento topico segun la especialidad.

4) nefrológico: aclarar que ingreso con insuficiencia renal con que valor de creatinina ingreso y con cual egresa.

16. [BAD] - 20/01/2026 22:28 > • Cabe mencionar que la caída fue en la vía pública, que fue una caída de

propia altura sentada y sin TEC (éste último dato muy importante), y que ingresó a Emergencias en ambulancia • No se consigna la medicación habitual para sus antecedentes patológicos • No es necesario aclarar "clavo tipo gama". Suficiente con reducción abierta y fijación interna, o a lo sumo clavo endomedular y tornillos

17. [BAD] - 20/01/2026 21:50 > • Bien colocados los antecedentes • No esta consignada su medicación habitual en ninguna parte de la epicrisis • "Ingresa por cuadro de 1 semana de evolución de excitación psicomotriz y negativismo a la ingesta." Corresponde ponerlo en tiempo pasado > ingresó a Emergencias… • "Se constató óbito a las 21:45 hs. Causa de fallecimiento: insuficiencia respiratoria aguda, falla multiorgánica, sepsis a foco urinario." Es correcto incluir el horario del óbito, pero está mal la interpretación de las causas. Esas 3 causas de muerte son las requeridas legalmente en Argentina (causas directa o final, causa interviniente y causa básica). A menos que se aclare cada una de ellas, con esos títulos y orden, en la epicrisis de defunción no es necesario ponerlo.

18. [BAD] - 20/01/2026 21:19 > • Mejorar redacción: "Paciente femenina de 18 años con antecedente de exéresis de Xantoastrocitoma Pleomorfico en 2019 en Hospital Garrahan, que requirió quimioterapia psoteriormente por dos años (se desconoce esquema)." • Poner en pasado "RMN evidenció nuevo crecimiento…" • Mala redacción e incorrecta al decir "Al ingreso, neurológicamente conservada". Ese término así escrito no existe en la jerga. Sería correcto. "Al ingreso, sin focos neurológicos agudos" • Correcta redacción y evolución en "Durante la internación se realizó exéresis total de la LOE bajo REMAIN y fluoresceína. Postoperatorio inmediato en UTI, luego pase a sala general sin complicaciones." • Falta agregar en "Intercurre con broncoespasmo y estridor, requiriendo nebulizaciones y corticoides EV, con buena respuesta" que la interpretación es edema glótico postoperatorio • No se entiende porque se realiza un doppler venoso, aclarar que presentó asimetría de miembros superiores y se realizó la ecografía que no evidenció trombosis

19. [BAD] - 20/01/2026 20:00 > 1. Incompleta la parte de los antecedentes patológicos. Se mencionan en diferentes evoluciones clínicas. Para que quede completo, los antecedentes patológicos de esta paciente son los siguientes: HTA, DLP, AIT x2, resección de adenomas paratiroideos, último en 3/2025 en Hospital Universitario Austral, febrero/2025 episodio de síncope, con realización de TC con evidencia de lesión talámica. Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía, colecistectomía, cirugía ocular (por miopía?) en ojo derecho. Es muy importante aclarar los antecedentes patológicos de forma completa antes de describir la enfermedad actual y evolución. También al redactar, es mejor no abreviar (y escribir hipertensión arterial en vez de HTA, por ejemplo) 2. No se precisa la medicación habitual de la paciente: valsartán 80 mg/día, caclitriol 0,25, calcio 600 mg, vitamina d3, AAS 100, atorvastatina 40, omeprazol 20 mg 3. Sería mejor para la redacción precisar todos los eventos en tiempo pasado, por ejemplo "ingresó a Emergencias" o "consultó a Emergencias por…", y si es un servicio determinado del hospital/sanatorio, precisarlo en mayúsculas. 4. Falta elaborar el estado clínico de la paciente en la consulta a Emergencias! Dato omitido más que importante, precisar signos vitales! También que ante hallazgo de LOE (lesión ocupante de espació) se decidió su internación en la Unidad de Cuidados Intensivos para monitoreo neurológico. 5. También corresponde precisar todo lo ocurrido en UCI/UTI en tiempo pasado. 6. Están bien aclaradas las interconsultas, pero incorrecta la aclaración de "descartándose etiología infecciosa". Eso solo puede realizarse ante un cultivo tomado del sitio sospechoso, lo cual no fue hecho. Lo correcto sería aclarar que el test de HIV fue negativo, y que el cuadro y evolución clínica no impresionaron que la causa sea infecciosa, más bien posiblemente oncológica 7. No se mencionó en la epicrisis que se realizó Interconsulta con Hematología y se decidió inicio de anticoagulación con HBPM 60mg/12 hs por evidencia de trombosis en seno recto en angioRMN. 8. Falta aclarar por qué no se concreta la biopsia estereotáxica. Inicialmente esta se plantea antes de que la paciente se torne agresiva, pero faltaba la aprobación de materiales por obra social 9. Agregaría en la evolución clínica que además la paciente se tornó agresiva, que hubo un llamado a la fuerza policial y se habló con paciente y familiares, interviniendo también la jefatura de servicio. 10. Mejorar redacción: "Se interconsulta a Psiquiatría, quienes indican quetiapina y clonazepam, y seguimiento ambulatorio al momento de indicarse el alta médica" 11. Corresponde explicar lo sucedido respecto al alta voluntaria en otro párrafo 12. Bien aclarado que el alta voluntaria fue firmada por sus familiares, en este caso hijas 13. Aclararía que quedó pendiente la realización de angiografía digital (no mencionada en la epicrisis) y eventual biopsia estereotáxica.

20. [PARTIAL] - 20/01/2026 18:48 > La redacción está bien pero tiene omisiones y errores en el relato. Cuando tiene el episodio de clonus se inicia levetiracetam pero cuando posteriormente presenta el deterioro del sensorio (que fue secundario a hidrocefalia aguda) se agrega fenitoína como segunda medicación anticonvulsivante. Es importante detallar aquí y en el apartado de medicaciones. Además posteriormente cuando no presentaba respuesta neurológica, por sospecha de un status epileptico no convulsivo se inicia sedación con midazolam (no tolera propofol por bradicardia) y se realiza un EEG que tenia un rimo lentificado sin descargas. Todo esto es fundamental que esté relatado porque permite comprender el cuadro clínico y la conducta, y además habla de intolerancia a farmacos que es un apartado que no debe faltar. Cuando se diagnostica la neumonía intrahospitalaria se aisla un Staphylococcus aureus meticilino sensible en aspirado traqueal por lo que el tratamiento antibiótico con cefazolina fue DIRIGIDO

y falta aclarar que hizo 7 días totales (finalizando el 04/05). Cuando se realiza el segundo EEG de control (el primero tenia un ritmo lentificado) se suspende fenitoina y queda solo con leveitacetam. Cuando presentó diarrea además se tomaron muestras de coprocultivo y toxina para clostridium difficile que fueron negativas Se debe decir "reingreso/reinternación" en UTI En esta última instancia en UTI falta el diagnóstico definitivo que fue hidrocefalia aguda secundaria a disfunción de la válvula de derivación ventriculoperitoneal que motivó una segunda revisión, recambio y reposicionamiento del catéter proximal y recalibración (fue un procedimiento quirúrgico y no puede faltar). Un error es decir que pasa a sala con ATB endovenoso dado que no volvio a realizar antibióticos más que cefazolina.

21. [BAD] - 20/01/2026 02:55 > Falta el antecedente de IRC con Cr. basal de 3. Al ingreso presenta ademas del derrame pleural probnp de 1000. Este dato es relevante para este diagnóstico.

El balance negativo fue violento por 4 días con doble bloqueo (furosemida + hidroclorotiazida) lo que lleva a la mejoria sintomatica pero con deterioro de la función renal.

Hematología roto anticoagulación por la caida del filtrado glomerular, lo que contraindica el apixaban.

Al 7mo día se inicia leve balance positivo por deterioro de la función renal. a las 48hs se ve mejoría. En el contexto de este deterioro y ante la posibilidad de requerir dialisis la paciente se niega. Esto es importante aclarar que se niega no ante la necesidad de dialisis sino que se niega de forma preventiva. Por este motivo no creo que sea de valor ponerlo en la epicrisis.

Se internó durante 9 días en Unidad coronaria y luego pasa a sala. es importante colocar la estancia en unidad cerrada con fechas.

Del 7mo al día 14 presenta balance neutro positivo sin signos de insuficiencia cardíaca y con mejora de la función renal hasta su creatinina basal (2,3).

22. [BAD] - 20/01/2026 02:25 > dice que se solicito ic con cardiología pero no esta la evaluación cardiologica que descarta toxicidad. Esto fue previo a los pulsos de corticoides.

Es importante respetar el orden cronológico de ocurrencia. Los pulsos de corticoide fueron el tratamiento y luego mejora levemente dandose el alta con seguimiento ambulatorio.

Dicocolon no, dolicocolon. Es importante mantener lenguaje medico a pesar que haya errores en la escritura de la HC.

Debe ser mas extensa y detallada la hc. Los pulsos de corticoides fueron de 5 días.

23. [PARTIAL] - 20/01/2026 01:52 > si bien es verdad que la paciente estuvo varios días esperando el procedimiento, puede detallarse mas la sucesión de estudios y el tratamiento analgesico. Por ejemplo puede expresarse. Se inicia tratamiento analgesico con opioides, aines y corticoides con respuesta parcial. Es evaluado por cirugía de columna proponiendo resolución quirúrgica.

24. [PARTIAL] - 19/01/2026 23:05 > En cuanto a los antecedentes faltan dos de mucha jerarquía para el cuadro actual: -La realización de limpieza y liberación de la válvula mitral protésica en enero por pannus. -La consulta previa por lumbalgia. Ambos pueden ser totalmente determinantes en el cuadro de endocarditis infecciosa, sobretodo secundaria a staphylococcus. En cuanto a la enfermedad actual falta consignar la gravedad del COVID, en este caso fue leve. Es imprescindible la aclaración de los días realizados de cada antibiótico en el caso de cuadros infecciosos. En cuanto a los estudios complementarios siempre detallar los hallazgos de los mismos, en este caso el ETE además de las vegetaciones presentaba dos jets de regurgitación mitral que son imprescindibles para interpretar la gravedad del cuadro y plantear el tratamiento. Además se debe aclarar que por este motivo fue evaluado por cirugía cardiovascular quienes solicitaron un ETT de control a los 5 días que no mostro progresión de la insuficiencia valvular, por lo que se decidió conducta quirúrgica expectante. Como ves, esto es fundamental porque marca la gravedad del cuadro y explica la conducta. En cuanto a la descripción del otro problema asociado en la internación que fue la insuficiencia renal aguda falta la gravedad de la misma (grado de la clasificación de AKI) y aclarar que por este motivo se decide monitorización de vancocinemia y permanencia del paciente en internación para completar 14 días de gentamicina. Esto es porque vancomicina y gentamicina son nefrotóxicos y requerían una monitorización analítica estricta, en este caso de fundamental importancia para justificar la estancia hospitalaria.

25. [BAD] - 19/01/2026 15:07 > ERC (Seguimiento por nefrología) esto no aporta valor a la epicrisis. Si aporta valor cual es la creatinina basal conocida. Al mismo tiempo se sabe que es monoreno funcional

En un paciente con ERC es importante saber el nivel de creatinina basal para setear objetivos.

TA 80/40 debe decir como revirtió (en este caso con cristaloides)

ante un valor anormal de signos vitales es importante saber que intervención se tomó.

Es importante colocar la duración de la antibioticoterapia, es decir, cuantos días recibió ceftriaxona o cuantas dosis totales.

Hematología descarto clonalidad y continúa tratamiento ambulatorio. el resumen es incorrecto.

26. [BAD] - 19/01/2026 13:24 > 1. No se aclaran los antecedentes patológicos de la paciente (HTA, marcapasos, diabetes, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, RTC bilateral, deterioro cognitivo crónico, insuficiencia venosa). Si se aclara que esta institucionalizada, postrada, y en posición viciosa, pero es necesario aclarar el contexto de ello, y dar conocimiento de los antecedentes patológicos personales 2. No se aclara dónde está institucionalizada, este contexto es importante, y cómo fue derivada (por médico en ambulancia) 3. Mejorar redacción de cómo se encontraba la paciente al examen físico, y agregar el dato de que se encontraba hemodinámicamente estable 4. Mejorar redacción de hallazgos positivos en laboratorio. Sí están bien los seleccionados. 5. Mejorar redacción, por ejemplo "Se solicitó tomografía de tórax, abdomen y pelvis que evidenció…" 6. Correcto colocar la interpretación del cuadro (sepsis a foco de piel y partes blandas) 7. "Se inició antibioticoterapia empírica (vanco y piperacilina/tazobactam)" en esa frase, no abreviar vanco por vancomicina. Asimismo, esa frase debería ir antes de los hallazgos en cultivos porque es lo que se realizó empíricamente (antes de conocer los resultados). De hecho, al conocerse, se rotó el piperacilina/tazobactam por meropenem. 8. Mejorar redacción de "Cirugía plástica realizó escarectomía". Sería mejor "se realizó interconsulta con Servicio de Cirugía Plástica y se realizó escarectomía en la habitación, sólo removiendo tejido necrótico desvitalizado". 9. Ampliar un poco el contexto en el que la paciente evoluciona desfavorablemente. Aclarar excitación psicomotriz, dolor total, desasosiego, etcétera. 10. Es muy importante en un paciente que entra a cuidados paliativos, explicar como se decide eso, y siempre aclarar si es en acuerdo con la familia. Éste es el caso, por ende mejorar la redacción de "Se decidió cuidados paliativos." 11. No se aclara que, en conjunto con familiar, se decidió sedación paliativa. Dato absolutamente clave! 12. "Se constató óbito el 17/01 a las 04:50 hs por falla multiorgánica, insuficiencia respiratoria aguda y sepsis." Es correcto incluir el horario del óbito, pero está mal la interpretación de las causas. Esas 3 causas de muerte son las requeridas legalmente en Argentina (causas directa o final, causa interviniente y causa básica). A menos que se aclare cada una de ellas, con esos títulos y orden, en la epicrisis de defunción no es necesario ponerlo.

27. [PARTIAL] - 19/01/2026 01:10 > Los antecedentes personales tienen que organizarse y agruparse, y ser lo más claros posibles, declarando tambien los aspectos que no se conocen. En este caso el deterioro cognitivo severo es la CAUSA de la geriatrización y de los trastornos de la deglución (puede aclararse de esta manera). Luego en la TAC de cerebro aparece un índice de evans mayor a 0,3, lo que se sugestivo de hidrocefalia normotensiva como causa del deterioro. En estos casos se pueden tomar datos de la internación actual que nos permitan entender los antecedentes y dejarlo como diagnóstico sugerido o sospecha (según interpretación). En los antecedentes falta el trastorno de deglución que es importante porque fue uno de los aspectos evaluados en la internación. En la enfermedad actual falta la hematuria, en este caso un dato fundamental porque es el signo que lleva a la sospecha de infección urinaria. Luego está muy bien la interpretación diagnóstica, pero esta debe ser COMPLETA, cronológica y completa, siguiendo los supuestos en este orden: interpretación diagnóstica (sindrome o etiología definida), gravedad del mismo (lo más preciso posible), estudios complementarios realizados para aprobar o rechazar la hipótesis diagnóstica con descripción de datos relevantes de los mismos, y terapéutica instaurada. En este caso se destacan: -Infección urinaria. Se deja claro que el agente etiológico es una klebsiella, pero se debe aclarar su perfil de resistencia (resistente a carbapenemes, sensible a aztreonam y colistín) y donde se halló (en este caso sólo en urocultivo), dado que permite entender la conducta terapéutica. Además se aclara que se suspendió piperacilina-tazobactam pero no aclara que antibiótico se indicó y POR CUANTOS DIAS, dato que nunca debe faltar. En este caso realizó colistín por 5 días. -Bicitopenia (anemia y plaquetopenia). Esto no está detallado en el relato. Se interpretó de etiología carencial por déficit de hierro y ácido fólico y se repusieron los mismos. Esto no puede obviarse y debe detallarse de acuerdo a los supuestos establecidos. -Alteración del hepatograma. Tampoco está especificado. Por esto se realizó una ecografía normal y se interpretó como seuncaria al cuadro infeccioso. Siempre debe hacerse una conclusión diagnóstico/terapéutica del problema. -Disfagia, que por términos probabilísticos se relaciona con su deterioro congitivo y ya la traía previamente. Por esto fue evaluada por fonoaudiología que realizó ajuste de la consistencia de alimentos. Esto está especificado parcialmente y debe dejarse escrito de forma clara y ordenada.

28. [PARTIAL] - 19/01/2026 00:38 > Es importante que todos los antecedentes relevantes para la enfermedad actual estén especificados con el máximo detalle, como en este caso la trombocitosis. A su vez siempre revisar todas las evoluciones dado que al ingreso puede no estar el antecedente, o estar incompleto o erroneo, y construirlo al final para dar mayor visibilidad de su relación del cuadro con precisión. En este caso el paciente tenía una trombocitosis en estudio por hematología con sospecha de sindrome mieloproliferativo (trombocitosis esencial), y estaba realizando

aspirina que discontinuó en el postoperatorio. Dato muy relevante en un caso de TEP. Los estudios deben interpretarse y resumirse adecuadamente, en este caso el laboratorio mostraba insuficiencia renal aguda, hiponatremia, troponina y dimero D positivo. Luego ordenar la interpretación diagnóstica (síndrome o etiología definitiva), gravedad de la misma y terapeutica instaurada, de cada uno de los diagnósticos (a veces son mas de uno). En este caso TEP (de riesgo intermedio alto por disfunción del ventrículo derecho en ecocardiograma y biomarcadores de daño miocardico, si es posible siempre agregar un score que ayuda a entender gravedad, como en este caso el PESI simplificado de 3, y se instauro heparina no fraccionada por falla renal), insuficiencia renal aguda (AKI II no oligurica por lo que se realizo fluidoterapia) y sospecha de neumonía intrahospitalaria (por radioopacidad basal izquierda, se tomaron cultivos y se inicio piperacilina-tazobactam). En anbitióticos simpre aclarar días totales (o fecha de inicio y fin)

29. [PARTIAL] - 19/01/2026 00:26 > Es importante describir con mayor profundidad los antecedentes que tienen relación con el cuadro actual, como en este caso la trombocitosis. Recordar que los mismos pueden ir surgiendo en el relato de las evoluciones y no siempre están (o son correctos o completos) al ingreso. En este caso la trombocitosis estaba en estudio por hematología con sospecha de trombocitosis esencial (sindrome mieloproliferativo) y se encontraba antiagregado con aspirina que no había retomado posterior a la cirugía (este es un dato de mucho peso en este caso que se trata de una complicación trombótica). Está correcta la descripción de los estudios complementarios pero es importante la intrepretación diagnóstica (ya sea síndrome o etiología definitiva) asi como la clasificación de gravedad/pronóstico. En este caso se trata de un tromboembolismo de pulmon de riesgo intermedio/alto, dado que tiene disfunción imagenológica del ventrículo derecho y biomarcadores de daño miocárdico positivos (troponina), esto es muy importante y tiene que estar aclarado, y si es posible adjuntar algún score de severidad, como en este caso el PESI simplificado que aparece en las evoluciones. Es posible que en algunos casos haya dos o más problemas activos o diagnósticos etiológicos. En estos casos se debe ordenar los mismos, en todos los casos poner la interpretación diagnóstica, la evaluación de gravedad y la terapéutica instaurada para cada uno de forma consecutiva. Aquí por ejemplo además tenía una insuficiencia renal aguda multifactorial (que fue la que determinó que se elija heparina no fraccionada en infusión continua para tratar el TEP) por la que se instauró fluidoterapia con cristaloides y una radioopacidad basal izquierda con sospecha de neumonía intrahospitalaria por lo que se inició piperacilina-tazobactam. Siempre que se hable de un antibiótico se deben aclarar los días totales de realización (o fecha de inicio y fin).

30. [PARTIAL] - 17/01/2026 15:49 > Falta aclarar en antecedentes que la obstrucción fue secundaria a bridas por apendicetomía previa. Aclarar que el antibiótico lo recibió únicamente por 24hs y luego se suspendió. Aclarar que tuvo solo 24 hs la sonda nasogástrica (SNG, evitar abreviar) con escaso débito, eso nos ayuda a ver la evolución de la paciente e interpretar la gravedad del cuadro.

31. [BAD] - 17/01/2026 15:22 > Falta aclarar antecedentes personales: polineuropatía diabética, glaucoma, hipoacusia y el más importante es que tuvo un procedimiento días previos el 17/12 (una ureteroscopía). Todo esto es importante aclararlo por que cambia en la elección el antibiótico y tiempo de tratamiento. No tuvo alucinaciones en esta oportunidad, eso es un antecedente. Hay que mejorar la redacción ej.: A su ingreso se realizo ecografía con residuo posticcional elevado se realizo laboratorio con videncia de creatinina de 6.5. Se INTERPRETó como insuficiencia renal aguda postrenal la cual mejoro hasta su normalidad con colocación de sonda vesical. Hay que explicar porque se decidió poner antibiótico (ej. por sintomatología, asociado procedimiento reciente, y estudios se interpreta como pielonefritis sin rescate en urocultivo al momento motivo por el cual e inicia ceftriaxona. En conclusión, se arma tan resumido todo que no se entiende.

32. [PARTIAL] - 17/01/2026 14:45 > Esta muy resumido y no se entiende que interpreto el médico. Al desglosarlo por sistemas es más simple entender que estudios se pidieron y por qué. Ej: en un inicio se sospechó infección de piel y partes blandas pero posterior a estudios solicitados (TAC de tórax) se constata neumonía que se interpreta como intrahospitalaria y por eso la elección del antibiótico piperacilina tazobactam (PTZ). Falta aclarar que se interpreta mala evolución en contexto oncológico de la paciente con mesotelioma avanzado y que se habla con los familiares y se decide priorizar confort evitando maniobras invasivas, por lo cual se procede a sedoanalgesia por malestar y disconfort de la paciente.

33. [PARTIAL] - 17/01/2026 14:16 > Faltan antecedentes (están incompletos) y medicación habitual.

34. [BAD] - 17/01/2026 13:46 > 1) Faltan antecedentes: SCASEST (significa sidnrome oronario gudo sin elevación del st= + EAp edema agudo de pulmón, agregar quela colocación e marcapasos s por bloqueo AV de alto grado, Insuficiencia respiratoria por NAC e infeccion urinaria por SAMS y E coli respectivamente (08/2021) con requerimeinto e itubación orotraquel (es importante saber si un paciente estuvo intubado, cuando y cuánto tiempo por las secuelas que peude tener. 2023 Edema agudo de pulmon hieprtensivo con requerimeinto e ventilación no invasiva, hiponatremia pro diureticos. 2) Falta medicación habitual. Es necesaria para saber cuales se modifican l alta y por sus efectos adversos e interacciones. 3) Está muy resumido lo que le sucedió a la paciente es importante dividir los

problemas por sistemas. Ej: Nefrologico ingreso con insuficiencia renal con creatiniand 1.6 y con hidratación resolvió egresando con creatinina de 1.3. Neurológico: Por clíncia se interpreta como ACV isquemico (sin posibilidad ahcer resonancia por marcapasos no reasonable) por lo que se la medica para dicha patología, evidencia e hematoma subgaleal sin conducta por neurologia. Traumatologico: NO tiene luxación, era una sospecha, luego e la tac se confirmo lesión de supraespinoso y e le indico cabestrillo y eguimiento por consultorios externos.

35. [PARTIAL] - 17/01/2026 13:39 > Dentro de los antecedentes es importante también las consultas previas en relación a la enfermedad actual, por ejemplo en este caso hace 48 horas presentó retención aguda de orina, se realizó sondaje vesical en domicilio y posteriormente evoluciona con deterioro del sensorio. El relato debe seguir un orden cronológico, sin embargo es importante que se describa la presunción clínica o hipótesis diagnóstica al ingreso, los estudios complementarios solicitados con su resultado y la terapéutica instaurada en este orden. Posteriormente un resumen/relato cronológico de la evolución. No se deben repetir sucesos (nombrar varias veces el mismo cultivo, o interconsulta, o estudio solicitado). En caso de los estudios complementarios detallar los hallazgos patológicos de forma textual agregando una interpretación de los mismos. En este caso la TAC de torax evidenciaba una consolidación basal izquierda sugestiva de neumonía, y la TAC de abdomen y pelvis una dilatación pielocalicial bilateral a predominio izquierdo sin etiología obstructiva clara. Cada uno de los diagnósticos etiológicos deben describirse con la mayor precisión posible en cuanto a etiología y gravedad. Por ejemplo en este caso síndrome febril con foco urinario (infección urinaria con aislamiento de streptococcus viridans con sensibilidad especificiada) y respiratorio (neumonía adquirida en la comunidad). En este caso es importante detallar la toma de cultivo, los aislamientos y antibiograma. Además tuvo una hiponatremia severa (116), hipoosmolar hipovolémica que respondió a la reposición, y una insuficiencia renal aguda AKI II de etiología mixta (pre-renal y obstructiva) que resolvió con sondaje e hidratación. Esto es muy importante, detallar etiología, mecanismo, gravedad y resultado del tratamiento.

36. [PARTIAL] - 17/01/2026 12:51 > Está correcta la priorización de antecedentes relevantes, en este caso el antecedente quirúrgico reciente. En este caso se debe ser lo más preciso posible en su descripción dado que tiene relación con el motivo de internación. Tener en cuenta que los antecedentes se van construyendo y conociendo durante las diversas evoluciones por lo que deben controlarse y actualizarse con cada evolución de un profesional. En este caso fue una eventroplastia gigante con adhesiolisis y colocación de material protésico (malla). Luego siempre se debe realizar una descripción cronológica del cuadro. Primero identificar los datos importantes, luego establecer el diagnóstico sindrómico/etiológico, luego aclarar los estudios complementarios realizados para confirmar o refutar hipótesis, o para la toma de conducta, y luego la conducta terapéutica. Siempre en orden cronológico, destacando la fecha o día de internación del suceso. En el caso de los antibióticos siempre consignar los días totales (idealmente fecha de inicio y finalización). Aquí se realizó una TAC que evidenció una colección en el tejido celular subcutaneo abdominal en relación a la malla, tener en cuenta que no fue laminar, es preferible evitar calificativos y detallar lo que informa la tomografía inicial. Primero se intentó realizar un drenaje quirúrgico percutaneo a ciegas sin éxito y posteriormente se realizó un drenaje eco-guiado percutáneo. Se tomaron hemocultivos, urocultivo, coprocultivo, toxina para clostridium difficile, hisopado anal de portación y cultivo de líquido de drenaje. Se instauró tratamiento antibiótico empírico. Al septimo día se realizo ecografía de control que evidenció reducción pero persistencia de la colección por lo que se realizó nuevo drenaje, y luego una TAC de abdomen de control con evidencia de mejoría imagenológica. Es importante destacar la secuencia cronológica para entender las definiciones terapéuticas. Siempre seguir este camino de relato y controlar cronológicamente su aparición en las evoluciones.

37. [PARTIAL] - 16/01/2026 23:43 > En este caso corresponde clarificar un poco mejor los antecedentes, dado que son muy relevantes para el cuadro clínico. Tener en cuenta que los antecedentes se van construyendo durante la historia clínica y no solo al ingreso, incluso con los estudios complementarios, por ejemplo aquí podríamos decir que es una paciente con antecedente de cáncer de vejiga por lo que se realizó cistectomía radical e histerectomía con construcción de neovejiga, y posteriormente realizó tratamiento quimioterapico en 2016. No tenemos muchos datos acerca del tumor de parótida, y eso hay que registrarlo. Tener en cuenta que previamente venía realizando AMC (que es amoxicilina/ácido clavulánico, no ampicilina/sulbactam) y dejar claros cuántos días hizo y dirigido a que rescate microbiológico, en este caso una Klebsiella pneumoniae sensible, dado que esto permite comprender que al ingreso se haya decidido continuar con el mismo antibiótico (en este caso con posología endovenosa). Agregar una interpretación del cuadro inicial, al ingreso se intrepreta como una infección urinaria complicada y se continúa antibiótico dirigido al rescate previo, esto es importante dejarlo especificado dado que permite comprender la conducta terapéutica. Dejar claro el motivo de pedido de estudios complementarios, en este caso la ecografía abdominal se pide por alteraciones mixtas (hepatocelulares/colestasicas) del hepatograma para descartar patología estructural. En este sentido, luego aparece que las alteraciones del hepatograma eran previas y tenia un anticuerpo anti-musculo liso positivo, dato de gran relevancia para reintepretar el cuadro, por lo que debería aparecer consignado explicitamente. Luego dejar claro en que día (fecha) de la internación repite fiebre y cuantos días totales de antibióticos se completaron. En este caso

el PET-CT se pide para estudio etiológico (sospecha de fiebre tumoral, inmunológica, foco infeccioso oculto), esto lo debés entender y dejar claro.

38. [BAD] - 16/01/2026 18:17 > Debe colocarse el antecendente de cirugía reciente (15 días antes de la internación) La secuencia temporal es importante para entender el diagnóstico.

Falta el drenaje del seroma

Que infectología retire el antibiótico no aporta valor. -solo debe constatar que interpretado como TEP se retira antibioticoterapia.

La redacción es confusa. debe constatar que evoluciona favorablemente, pero con aumento de la got y gpt por lo que se decide conducta expectante y dieta.

39. [PARTIAL] - 16/01/2026 13:51 > Está bien aclarado en la primera TAC que sugiere perforación, pero debería explicitarse el informe de la segunda TAC (con contraste) que no evidencia pase de la sustancia de contraste a peritoneo (perforación), dado que esto es fundamental en relación a la conducta quirúrgica y el diagnóstico intraoperatorio. Siempre los estudios por imagenes deben consignarse de la forma más fiel posible en cuanto a resultados porque pueden modificar la interpetación y conducta. Se debe especificar qué antibiotico/antibioticos recibió y durante cuántos dias, dado que esto es fundamental para comprender la epidemiología y stewardship, y dato de indudable valor para internaciones futuras. A su vez, siempre consigar lo más fielmente posible la foja/parte quirúrgico en cuanto a las intervenciones realizadas (en este caso evacuación de hematoma, evaluación de indemnidad rectal, colocación de drenaje y confección de colostomía protectora).

40. [PARTIAL] - 16/01/2026 13:04 > En radioterapia "antigua" conviene no utilizar calificativos y ser lo más preciso posible (año aproximado), y aclarar por qué se realizó la misma (en este caso sin diagnostico claro), dado que permite diferenciar si tiene o no relevancia para el cuadro actual. Tratar de priorizar en la lista de antecedentes personales los que tienen relevancia para el cuadro clínico (en este caso los urológicos) dado que el resto son datos secundarios). No se consigna que tuvo una consulta previa donde se fue de alta con ciprofloxacina, esto es muy importante porque contextualiza la gravedad del cuadro y explica la conducta terapéutica (en este caso la elección del antibiótico). En el laboratorio de ingreso se deberían definir los parámetros importantes para este caso, en una infección/sepsis utilizamos scores pronosticos como el SOFA, por lo que al menos debería incluir los valores necesarios para estimarlos (plaquetas, bilirrubina, creatinina, presión parcial de oxígeno si la hubiere), y además aclarar los reactantes de fase aguda elevados (en este caso PCR) que orientan a la etiología. Hay un error fundamental a la hora de interpretar el urocultivo. En primer lugar se debe explicitar el recuento de unidades formadoras de colonias y el gérmen rescatado, y en segundo lugar se debe interpetar el antibiograma. En este caso el gérmen no era resistente a piperacilina-tazobactam (antibiótico inicial) sino que no estaba probado en el antibiograma. El infectólogo dado que la evolución era tórpida rota a imipenem empíricamente y pide la ampliación del antibiograma, y este resultó ser sensible al antibiótico inicial, por lo que se descala a ceftriaxona y se cuentan DIAS TOTALES de antibióticos desde el ingreso. Esto tiene que estar consignado con la mayor precisión posible, dado que es el dato central del caso clínico.

41. [PARTIAL] - 16/01/2026 12:32 > Es muy importante consignar el tiempo de evolución del cuadro, sobretodo en focos neurológicos. Si es incierto como en este caso, hay que especificarlo. La TAC informaba edema peri-sangrado leve, en este caso de neuro-imagenes el informe tiene que ser lo más fiel posible y completo con respecto al real, dado que es dato de mucho valor a la hora de comprender la gravedad del cuadros y las conductas realizadas. No incluir estudios complementarios sin una interpetación de los mismos y las conductas que se tomaron al respecto, ejemplo: ECG con cambios de cara inferior (que tambien se ven en el ETT) se interpetaron como secuela isquémica, debe dejarse aclarado para diferenciar de un sindrome coronario agudo, que en este caso no se pensó como hipótesis por lo que no se hizo ningun estudio/procedimiento al respecto. Aclarar tiempo total en cuidados críticos y en sala general.

42. [BAD] - 16/01/2026 04:41 > La redacción es poco clara. Recomiendo seguir un algoritmo de Antecedentes y medicación habitual, para luego detallar el motivo de consulta y resumen de la internación.

Internación reciente debe aclarar fechas. en este caso Cursó internación 27/11/2025 al 03/12/2025. Al ser un antecedente de enfermedad actual tiene implicancias diagnósticas y pronósticas.

El deterioro de la función renal (en la hc deja claro los valores previos al ingreso) es importante.

Falta la interpretación diagnóstica del sindrome cardiorenal. En este caso se interpreta secundario al inicio de la terapia con SGLT1 que en inicios puede producir aumento de la cr. se realiza balance negativo con buena respuesta.

Falta la recomendación de hematología por anemia cronica de iniciar EPO.

43. [BAD] - 16/01/2026 04:25 > Se interpreto como HDA variceal (no se diagnosticó). -Es importante diferenciar lo que es probable de lo que esta confirmado. en este caso no se confirmo que el sangrado sea variceal.

IC con hepatología no aporta valor. Simplemente dice que fue evaluado por hepatología

IC con columna incompleto: falta la indicación de corset.

44. [BAD] - 15/01/2026 13:50 > -No colocaría consumo de alcohol. -El antecedente de Alcoholismo, salvo que sea un paciente con patología por alcohol declarada expone a riesgos legales dado que no es un antecedente constatable y puede estigmatizar.

-Es incorrecto que el paciente evolucióna con hipotensión en el pop inmediato. -Durante la intervención (y debido a la anestesia habitaulmente) requiere intervención con NA. No es un detalle de valor para la epicrisis siendo que el pop fue en sala y con buena evolución.

- No tuvo globo vesical
- El paciente tuvo disuria y tenesmo pero no se confirmo el globo vesical dado que el volumeno no fue correcto. Esto parte de una evolución de enfermeria que no es quien hace ni confirma diagnósticos, sino que aporta la sospecha. Se obtuvo muestra no inflamatoria considerandose e interpretandose como resistencia al tracto de salida (no especifica sospechando que, pero podría ser por edad por HPB + medicación para el dolor) y por eso el tratamiento es Tamsulosina.

Procedimientos

Estadísticas: - Total: 48 evaluaciones - OK: 13 | Parcial: 21 | Malo: 14 - Omisiones: 8 | Repeticiones: 9 | Confuso: 11

Feedbacks Individuales (48 registros):

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
1	28/01/2026 16:21	bad	-	Sí	Sí	No suma aclarar esto, excepto que se ponga el estudio con el informe correspondiente.
2	28/01/2026 01:46	bad	Sí	Sí	Sí	• No escribir en mayúsculas todo el texto • No corresponden: "CRANE-OTOMÍA EXPLORADORA CON O SIN BIOPSIA" y "CRANEOPLAS-TIA", en su lugar, corresponde "Excéresis de recidiva de glioma de alto grado" •
3	27/01/2026 21:39	bad	Sí	Sí	Sí	No aclara que se realiza extraccion de JJ. Esta sección no es necesaria para una epicrisis

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
4	27/01/2026 21:04	partial	-	-	Sí	• No están en orden cronológico las imá-genes/procedimientos
5	27/01/2026 13:28	ok	-	-	-	-
6	27/01/2026 03:32	bad	Sí	Sí	-	• ATC a CX (debe poner que stent usaron) • VEDA/VCC • Colocación de sonda vesical (Excedente) • Internación en UCI (Excedente) • Ecodoppler MMII • Ecocardiograma • Holter 24 horas • TAC abdomen y pelv
7	26/01/2026 17:35	ok	-	-	-	-
8	26/01/2026 16:09	bad	Sí	Sí	Sí	• Arteriografía de miembros inferiores: no verifico que haya sucedido realmente. • Intubación orotraqueal (IOT) y Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM): debe decir los días que tuvo. • Colocación de
9	24/01/2026 14:44	bad	-	Sí	Sí	Sacar todo este listo, no sirve. A lo sumo se puede agregar alguno de los estudios por imagenes para mostrar las complicaciones en postoperatorio ej: electroencefalo-grama o TAC de encefalo que muestra

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
10	23/01/2026 23:35	bad	Sí	Sí	Sí	En procedimientos quirúrgicos están puestos en varios items lo que se hizo en la cirugía inicial: craniectomia, resección tumoral y craneoplastia, forma parte del mismo procedimiento. Los estudios por
11	23/01/2026 13:09	partial	-	-	Sí	Los procedimientos listados están correctos. Se debe ordenarlos por categorías y remarcar brevemente los hallazgos de jerarquía en los más importantes
12	23/01/2026 13:08	ok	-	-	-	-
13	23/01/2026 12:28	partial	-	Sí	Sí	Lo principal es que los procedimientos deben estar ordenados por fecha de realización y por tipo de procedimiento. En este caso el ECG no forma parte importante de los estudios por este cuadro, así co
14	22/01/2026 21:55	bad	Sí	Sí	-	No sirve poner una lista de estudios que se hicieron si ya se aclararon los importantes en la evolución. Aportaría si se aclaran estudios realizados con la fecha y el informe
15	22/01/2026 20:39	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
16	21/01/2026 12:44	partial	Sí	-	Sí	laboratorio completo No es un termino médico, no significa nada. labo / ECG y placa de torax son constantes de ingreso. acá no figura que le hayan hecho placa. podría ser regla que figure este tandem
17	20/01/2026 22:28	ok	-	-	-	-
18	20/01/2026 21:50	ok	-	-	-	-
19	20/01/2026 21:19	ok	-	-	-	-
20	20/01/2026 20:01	ok	-	-	-	-
21	20/01/2026 18:50	partial	Sí	-	Sí	Los estudios deben caracterizarse con fecha de realización de los mismos. Además agruparlos por categoría. En este caso: Los procedimientos quirúrgicos fueron 3: resección del tumor, primera revisión
22	20/01/2026 02:55	partial	-	-	-	el hisopado es de vigilancia. no hace falta ponerlo
23	20/01/2026 02:25	bad	-	-	-	las ic son redundantes y estan colocadas en el apartado siguiente propio para este fin.
24	20/01/2026 02:25	bad	-	-	-	es importante colocar fecha de los estudios y resultados relevantes.
25	20/01/2026 01:52	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
26	19/01/2026 22:53	partial	-	-	-	Los estudios detallados son correctos. Es importante ordenar los mismos por fecha (día de realización) y categoría (analítica sanguínea, métodos por imagenes, métodos microbiológicos, procedimientos i
27	19/01/2026 15:07	ok	-	-	-	-
28	19/01/2026 13:25	bad	-	-	-	-Agregar fechas de los procedimientos, para más claridad -En los cultivos (hemocul-tivos/urocultivos, etc) alcarar las fechas de toma y los aislamientos con su sensibilidad, si los hubiera
29	19/01/2026 00:59	partial	-	-	-	Deben organizarse los procedimientos según su naturaleza con fecha de realización de los mismos. También se puede incluir un breve resumen de los resultados importantes para la internación actual. Se

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
30	19/01/2026 00:39	partial	-	-	-	Organizar los estudios complementarios y resumir los hallazgos de jerarquía. Siempre aclarar fecha de realización y si se realizaron más de un estudio del mismo tipo aclararlo con fecha. Estudios por
31	19/01/2026 00:28	partial	-	-	-	Se deben ordenar los procedimientos y es importante agregar la fecha de realización (o día de internación) de cada uno, dado que permite una asociación temporal. Además es importante clasificarlos de
32	18/01/2026 17:22	bad	-	-	-	el orden de los procedimientos consignados es incorrecto. no guardan relación ni con importancia, ni con prelación / orden de realización
33	17/01/2026 15:50	partial	-	-	-	Sacaría • Colocación de sonda nasogástrica • Retiro de sonda nasogástrica ya que no aporta. Agregaría informe de los estudios puestos.

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
34	17/01/2026 15:24	partial	-	-	-	Sacar sonda vesical. Pondría en orden cronológico lo que se hizo Ej: ecografía y luego urotomografía. Sino no se entiende para que hicieron una ecografía si ya tiene urotomografía. Al ponerlo en ord
35	17/01/2026 14:45	partial	-	-	-	Sacar colocación de sonda vesical, sacar vía periférica se sobreentiende sino no se podría aplicar los fármacos mencionados.
36	17/01/2026 14:17	partial	-	-	-	Si se aclaran los estudios realizados agregaría el informe, sino no tiene sentido volver a repetir todo lo que se hizo si ya está aclarado en la evolución
37	17/01/2026 13:48	partial	-	-	-	Solamente poner “laboratorio” no es necesario desglosar que cosas se pidieron en el laboratorio, se hace larga sino la epicrisis. Evaluar si agregar informe de cada estudio poniendo lo “positivo” las

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
38	17/01/2026 13:41	bad	-	-	-	Describir los procedimientos relevantes para el cuadro clínico ordenados por características del método y se puede incluir de forma opcional algo del resultado si es muy importante para el cuadro. En
39	17/01/2026 12:55	partial	-	-	-	Agregar las fechas o día de internación. Ordenar por carácter del procedimiento: metodos por imagenes, analisis microbiologico, analisis clínico, procedimientos quirúrgicos. En este caso faltan toxina
40	16/01/2026 23:44	partial	-	-	-	Sugiero ordenarlos por grupo de intervenciones (diagnóstico por imagenes, microbiología, analisis clínicos, tratamiento quirúrgico)
41	16/01/2026 18:17	ok	-	-	-	-
42	16/01/2026 14:00	partial	-	-	-	Falta sonda vesical, fue importante porque la realizó el urólogo por imposibilidad de enfermería

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
43	16/01/2026 13:53	partial	-	-	-	Deben ordenarse los procedimientos de acuerdo a su naturaleza. En este caso laparoscopia exploradora y confección de colostomía forman parte del mismo item (procedimiento quirúrgico). En cuanto a las
44	16/01/2026 13:04	ok	-	-	-	-
45	16/01/2026 12:34	partial	-	-	-	No es necesario consignar procedimientos poco importantes para el cuadro. La intervención del kinesiólogo es esperable en este cuadro, y formaría parte del sector de interconsultas, más que de procedi
46	16/01/2026 04:42	ok	-	-	-	-
47	16/01/2026 04:13	bad	-	-	-	VEDA no hace falta poner con sedación y es importante colocar las fechas En el caso de estudios repetidos permite saber la diferencias entre fechas y los requerimientos.
48	15/01/2026 13:53	partial	-	-	-	Falta sedimento urinario - Es importante porque es el que define la interpretación diagnóstica Muestra de urocultivo por enfermeria y urocultivo son redundantes. Solo colocar sedimento y urocultivo.

Comentarios Textuales Destacados (35 con texto):

1. [BAD] - 28/01/2026 16:21 > No suma aclarar esto, excepto que se ponga el estudio con el informe correspondiente.

2. [BAD] - 28/01/2026 01:46 > • No escribir en mayúsculas todo el texto • No corresponden: "CRANEOTOMÍA EXPLORADORA CON O SIN BIOPSIA" y "CRANEOPLASTIA", en su lugar, corresponde "Excéresis de recidiva de glioma de alto grado" • No corresponde "EXTUBACIÓN", corresponde "Asistencia respiratoria mecánica del 26/2 al 1/3" • No corresponde "GASOMETRÍA ARTERIAL, HEMOGRAMA, IONOGRAMA". Colocar en su lugar: "Laboratorios"

3. [BAD] - 27/01/2026 21:39 > No aclara que se realiza extraccion de JJ. Esta sección no es necesaria para una epicrisis

4. [PARTIAL] - 27/01/2026 21:04 > • No están en orden cronológico las imágenes/procedimientos

5. [BAD] - 27/01/2026 03:32 > • ATC a CX (debe poner que stent usaron) • VEDA/VCC • Colocación de sonda vesical (Excedente) • Internación en UCI (Excedente) • Ecodoppler MMII • Ecocardiograma • Holter 24 horas • TAC abdomen y pelvis • Hisopado rectal (Excedente) • Laboratorio (Excedente) • Radiografía de tórax (Excedente)

6. [BAD] - 26/01/2026 16:09 > • Arteriografía de miembros inferiores: no verifico que haya sucedido realmente. • Intubación orotraqueal (IOT) y Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM): debe decir los días que tuvo. • Colocación de catéter venoso central (CVC): sector de colocacoón • Curación compleja de úlceras en MMII: falta debridamiento • Colocación de sonda vesical: no aporta valor • Colocación de sonda nasogástrica (SNG): no aporta valor • Aspiración de secreciones: no aporta valor

7. [BAD] - 24/01/2026 14:44 > Sacar todo este listo, no sirve. A lo sumo se puede agregar alguno de los estudios por imagenes para mostrar las complicaciones en postoperatorio ej: electroencefalograma o TAC de encefalo que muestra fistula de LCR

8. [BAD] - 23/01/2026 23:35 > En procedimientos quirúrgicos están puestos en varios items lo que se hizo en la cirugía inicial: craniectomia, resección tumoral y craneoplastia, forma parte del mismo procedimiento. Los estudios por imagenes y microbiologicos deben estar ordenados por fecha y tipo de estudio (y se puede agregar los hallazgos importantes) La analítica sanguinea en este caso no forma parte de los estudios/procedimientos relevantes

9. [PARTIAL] - 23/01/2026 13:09 > Los procedimientos listados están correctos. Se debe ordenarlos por categorías y remarcar brevemente los hallazgos de jerarquía en los más importantes

10. [PARTIAL] - 23/01/2026 12:28 > Lo principal es que los procedimientos deben estar ordenados por fecha de realización y por tipo de procedimiento. En este caso el ECG no forma parte importante de los estudios por este cuadro, así como nombrar parámetros analíticos. En cuanto a la analítica destacar sólo lo de jerarquía.

11. [BAD] - 22/01/2026 21:55 > No sirve poner una lista de estudios que se hicieron si ya se aclararon los importantes en la evolución. Aportaría si se aclaran estudios realizados con la fecha y el informe

12. [PARTIAL] - 21/01/2026 12:44 > laboratorio completo No es un termino médico, no significa nada. labo / ECG y placa de torax son constantes de ingreso. acá no figura que le hayan hecho placa. podría ser regla que figure este tandem. Pero lo que hace ruido es el orden de la lista. es x jerarquía? debería ser cronológico laboratorio / ECG ingreso ecografia TC abdomen y pelvis que informa tórax (y debio tenerlo) paracentesis evacuadora reposición de sodio (estuvo días con esto ultimo que no está)

13. [PARTIAL] - 20/01/2026 18:50 > Los estudios deben caracterizarse con fecha de realización de los mismos. Además agruparlos por categoría. En este caso: Los procedimientos quirúrgicos fueron 3: resección del tumor, primera revisión valvular y recambio de cateter proximal, y segunda revisión valvular con recambio de cateter y reposicionamiento. En cuanto a los estudios de imagenes falta la RMI de craneo, y detallar que las TAC de craneo fueron varias y los EEG tambien Faltan los análisis microbiológicos.

14. [PARTIAL] - 20/01/2026 02:55 > el hisopado es de vigilancia. no hace falta ponerlo

15. [BAD] - 20/01/2026 02:25 > las ic son redundantes y estan colocadas en el apartado siguiente propio para este fin.

16. [BAD] - 20/01/2026 02:25 > es importante colocar fecha de los estudios y resultados relevantes.

17. [PARTIAL] - 19/01/2026 22:53 > Los estudios detallados son correctos. Es importante ordenar los mismos por fecha (día de realización) y categoría (analítica sanguínea, métodos por imagenes, métodos microbiológicos, procedimientos invasivos mayores y menores)

18. [BAD] - 19/01/2026 13:25 > -Agregar fechas de los procedimientos, para más claridad -En los cultivos (hemocultivos/urocultivos, etc) alcarar las fechas de toma y los aislamientos con su sensibilidad, si los hubiera

19. [PARTIAL] - 19/01/2026 00:59 > Deben organizarse los procedimientos según su naturaleza con fecha de realización de los mismos. También se puede incluir un breve resumen de los resultados importantes para la internación actual. Se deben obviar y no incluir aquellos procedimientos que no tienen relevancia, como instrumentaciones de enfermería, parámetros analíticos aislados o administración de medicación. En este caso corresponde: -Estudios por imagenes: TAC de craneo, torax, abdomen y pelvis, y ecografía abdominal. -Analítica. -Estudios microbiológicos: hemocultivos, urocultivo, toxina para clostridium.

20. [PARTIAL] - 19/01/2026 00:39 > Organizar los estudios complementarios y resumir los hallazgos de jerarquía. Siempre aclarar fecha de realización y si se realizaron más de un estudio del mismo tipo aclararlo con fecha. Estudios por imagenes con hallazgos principales Analítica con un resumen de los hallazgos de jerarquía Procedimientos quirúrgicos: no invasivos, invasivos, menores, mayores

21. [PARTIAL] - 19/01/2026 00:28 > Se deben ordenar los procedimientos y es importante agregar la fecha de realización (o día de internación) de cada uno, dado que permite una asociación temporal. Además es importante clasificarlos de acuerdo a su naturaleza (metodos por imagenes, metodos analíticos, procedimientos no invasivos, procedimientos quirúrgicos, etcetera), y aclarar un breve resumen de sus resultados en caso de ser relevantes. En este caso todas las determinaciones de laboratorio podrían juntarse en el apartado "analítica" y aclarar brevemente: insuficiencia renal, hiponatremia, troponina y dímero D positivo. De esta manera se organiza temporalmente y ayuda a comprender mejor la historia de la internación

22. [BAD] - 18/01/2026 17:22 > el orden de los procedimientos consignados es incorrecto. no guardan relación ni con importancia, ni con prelación / orden de realización

23. [PARTIAL] - 17/01/2026 15:50 > Sacaría • Colocación de sonda nasogástrica • Retiro de sonda nasogástrica ya que no aporta. Agregaría informe de los estudios puestos.

24. [PARTIAL] - 17/01/2026 15:24 > Sacar sonda vesical. Pondría en orden cronológico lo que se hizo Ej: ecografía y luego urotomografía. Sino no se entiende para que hicieron una ecografía si ya tiene urotomografía. Al ponerlo en orden se endiente que por algún motivo el médico decidió ampliar con estudios de mayor complejidad.

25. [PARTIAL] - 17/01/2026 14:45 > Sacar colocación de sonda vesical, sacar vía periférica se sobreentiende sino no se podría aplicar los fármacos mencionados.

26. [PARTIAL] - 17/01/2026 14:17 > Si se aclaran los estudios realizados agregaría el informe, sino no tiene sentido volver a repetir todo lo que se hizo si ya está aclarado en la evolución

27. [PARTIAL] - 17/01/2026 13:48 > Solamente poner "laboratorio" no es necesario desglosar que cosas se pidieron en el laboratorio, se hace larga sino la epicrisis. Evaluar si agregar informe de cada estudio poniendo lo "positivo" las cosas importantes.

28. [BAD] - 17/01/2026 13:41 > Describir los procedimientos relevantes para el cuadro clínico ordenados por características del método y se puede incluir de forma opcional algo del resultado si es muy importante para el cuadro. En este caso los procedimientos fueron: imagenes: TAC de torax, abdomen y pelvis. Analítica sanguinea: hiponatremia e insuficiencia renal. Cultivos: hemocultivos, urocultivo.

29. [PARTIAL] - 17/01/2026 12:55 > Agregar las fechas o día de internación. Ordenar por carácter del procedimiento: metodos por imagenes, analisis microbiologico, analisis clínico, procedimientos quirúrgicos. En este caso faltan toxina para clostridium y cultivo de colección. Si se trata de un cuadro con sospecha de infección es importante detallar con precisión los análisis microbiológicos. Se podría incluir un breve resumen de sus resultados en caso de que resulten determinantes en el cuadro actual.

30. [PARTIAL] - 16/01/2026 23:44 > Sugiero ordenarlos por grupo de intervenciones (diagnóstico por imagenes, microbiología, analisis clínicos, tratamiento quirúrgico)

31. [PARTIAL] - 16/01/2026 14:00 > Falta sonda vesical, fue importante porque la realizó el urólogo por imposibilidad de enfermería

32. [PARTIAL] - 16/01/2026 13:53 > Deben ordenarse los procedimientos de acuerdo a su naturaleza. En este caso laparoscopia exploradora y confección de colostomía forman parte del mismo item (procedimiento quirúrgico). En cuanto a las tomografías podría resumirse en con y sin contraste, en un mismo item. El examen perianal no forma parte de procedimientos, sino del examen físico realizado. El ECG en este caso no es relevante dado que no presentó ningun dato de valor para el caso, solo fue rutinario para la evaluación prequirurgica. En todos los casos debería consignarse en que fecha se realizó en procedimiento (o en qué día de internación).

33. [PARTIAL] - 16/01/2026 12:34 > No es necesario consignar procedimientos poco importantes para el cuadro. La intervención del kinesiólogo es esperable en este cuadro, y formaría parte del sector de interconsultas, más que de procedimientos. La extracción de laboratorio es algo banal y no debe consignarse. Sugiero que ordenes los procedimientos por tipo genérico: estudios por imágenes, estudios de laboratorio, estudios microbiológicos, procedimientos quirúrgicos, etcétera

34. [BAD] - 16/01/2026 04:13 > VEDA no hace falta poner con sedación y es importante colocar las fechas En el caso de estudios repetidos permite saber la diferencias entre fechas y los requerimientos.

35. [PARTIAL] - 15/01/2026 13:53 > Falta sedimento urinario - Es importante porque es el que define la interpretación diagnóstica

Muestra de urocultivo por enfermeria y urocultivo son redundantes. Solo colocar sedimento y urocultivo.

-Cateterismo vesical no corresponde -No fue el procedimiento principal sino una toma de muestra. Cuando colocamos cateterismo vesical en una epicrisis es un antecedente que se relacióna con posibles complicaciónes por lo que, es importante, detallar el tiempo. En este caso podria ser "cateterismo intermitente para toma de muestra de urocultivo y sedimento" asi diferenciamos del paciente que requiere sonda vesical durante uno o mas días.

Interconsultas

Estadísticas: - Total: 47 evaluaciones - OK: 16 | Parcial: 10 | Malo: 21 - Omisiones: 7 | Repeticiones: 8 | Confuso: 11

Feedbacks Individuales (47 registros):

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
1	28/01/2026 16:22	bad	-	Sí	Sí	Escribo de manera confusa, no suma esta seccion sino que confunde
2	28/01/2026 01:48	bad	Sí	Sí	Sí	• No corresponden "Seguimiento postquirúrgico y manejo de fístula de LCR, Manejo de convulsiones y evaluación del estado neurológico, Manejo de neumonía y meningitis." • No corresponde "Urología" •
3	27/01/2026 21:39	partial	-	-	Sí	No es necesaria esta seccion si se aclara en la evolucion

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
4	27/01/2026 21:05	partial	-	Sí	-	a Cardiología no solo se le interconsultó por el riesgo quirúrgico, asi que aclarar eso está de más
5	27/01/2026 13:28	ok	-	-	-	-
6	27/01/2026 03:32	ok	-	-	-	-
7	26/01/2026 17:35	ok	-	-	-	-
8	26/01/2026 16:09	ok	-	-	-	-
9	24/01/2026 14:45	partial	Sí	Sí	Sí	Tiene omisiones porque seguramente lo evaluó infectología, kinesiologia por ej. Excedentes tambien pro que no suma aclarar todo esto en listado cuando ya se conto en la evolución, repite mas de lo mi
10	23/01/2026 23:36	partial	Sí	Sí	Sí	Solo se deben listar las especialidades médicas intervinientes. En este caso falta neurocirugía (que fue la principal) e infectología (que se sumó en la última complicación infecciosa). “Seguimiento
11	23/01/2026 21:25	ok	-	-	-	-
12	23/01/2026 13:09	ok	-	-	-	-
13	23/01/2026 12:35	partial	-	-	Sí	Cuando no existen interconsultas realizadas se debe aclarar que no las hubo (como en este caso)
14	23/01/2026 12:29	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
15	22/01/2026 21:55	bad	-	Sí	Sí	no suma aclarar todas las interconsultas de esta manera en una epicrisis
16	22/01/2026 20:39	ok	-	-	-	-
17	21/01/2026 12:44	ok	-	-	-	-
18	20/01/2026 22:29	bad	Sí	-	Sí	No se aclaran los servicios de las interconsultas! Por ende no se entienden y quedan fuera de contexto los items.
19	20/01/2026 21:51	bad	Sí	Sí	Sí	Corresponde poner "Control de infecciones: aislamiento de contacto por tratarse de paciente institucionalizada". Así como está escrito, no se entiende interconsulta o seguimiento por quién o por qué
20	20/01/2026 21:19	ok	-	-	-	-
21	20/01/2026 20:05	bad	Sí	-	Sí	• No aclaran los servicios! Las interconsultas realizadas por estas paciente son a: Neurología, Neurocirugía, Neurointervencionismo, Infectología, Hematología, Psiquiatría • No se entienden los datos

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
22	20/01/2026 18:50	partial	Sí	Sí	Sí	La descripcion “ • Seguimiento por neumonía asociada a ventilación mecánica por SAMS. Se rota esquema antibiótico AMS x Cefazolina.” no implica una especialidad interviniente. Falta la intervención por
23	20/01/2026 02:55	bad	-	-	-	rin de la fecha no es una ic. es Hematología
24	20/01/2026 02:28	bad	-	-	-	valoración por cardiología. no hace falta por que fue porque es redundante con la evolución.
25	20/01/2026 01:53	bad	-	-	-	seguimiento? Evaluación y seguimiento por Cirugía de Columna
26	19/01/2026 22:54	partial	-	-	-	Se detalla “Estable hemodinámicamente, sin falla cardíaca ni lumbalgia. Iguales indicaciones cardiológicas”, lo cuál no es una especialidad médica interviniente. Falta la intervención de cirugía cardi
27	19/01/2026 15:07	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
28	19/01/2026 13:26	bad	-	-	-	Correcto la interconsulta a Cirugía Plástica. Es incorrecto “Se indica priorizar confort clínico, inicio de morfina + midazolam IV.” Eso es una indicación, no un servicio de interconsulta. Corresponde
29	19/01/2026 00:56	partial	-	-	-	Se deben nombrar las especialidades intervinientes y opcionalmente algún resumen del motivo de la interconsulta o si hubo un cambio importante de la conducta en relación al motivo de internación. En e
30	19/01/2026 00:39	ok	-	-	-	-
31	19/01/2026 00:28	ok	-	-	-	-
32	18/01/2026 17:34	partial	-	-	-	si bien el clinico ve al paciente, y puede considerarse una IC inicial el llamado a cirugía, hecho el diagnóstico es 1 paciente quirúrgico. es de ESE servicio.
33	17/01/2026 15:50	bad	-	-	-	Sacarlo, no suma
34	17/01/2026 15:24	bad	-	-	-	No repetirlo
35	17/01/2026 14:46	partial	-	-	-	Innecesario aclarar.
36	17/01/2026 14:17	bad	-	-	-	Ya aclarado previamente no repetir

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
37	17/01/2026 13:51	bad	-	-	-	Sacaría esta sección, ya esta aclarado todo en la evolución y repite lo que aclarado o informado
38	17/01/2026 13:42	bad	-	-	-	Solo consignar las especialidades involucradas en un listado, y opcionalmente el motivo de su intervención. En este caso: clínica médica, infectología y fonoaudiología (en este caso importante por dis
39	17/01/2026 12:56	bad	-	-	-	Identificar concretamente las especialidades involucradas y su eventual participación o motivo de intervención. En este caso: clínica médica, infectología y cirugía general
40	16/01/2026 23:45	bad	-	-	-	Esta sección no tiene los contenidos que debe tener. Siempre dejar una lista de especialidades intervinientes y se puede agregar un pequeño detalle del motivo de su intervención. En este caso: -Clinic
41	16/01/2026 18:18	bad	-	-	-	no sugiere ribaroxaban. Se anticoagula con hbpm y se rota a ribaroxaban al alta

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
42	16/01/2026 13:55	bad	-	-	-	Las interconsultas aquí fueron: Clínica médica, cirugía general y urología. Se deben identificar las especialidades participantes y ponerlas en una lista. Se podría agregar si alguna intervención de i
43	16/01/2026 13:05	bad	-	-	-	No están bien consignadas las interconsultas, hay repeticiones y datos que no corresponden. En este caso las interconsultas fueron: clínica médica, infectología y urología. Se podría agregar nutrición
44	16/01/2026 12:35	bad	-	-	-	Este sector no describe lo que tiene que describir, que son las especialidades que formaron parte de la evaluación. En este caso: neurología, neurocirugía y hematología
45	16/01/2026 04:42	ok	-	-	-	-
46	16/01/2026 04:14	ok	-	-	-	-
47	15/01/2026 13:53	ok	-	-	-	-

Comentarios Textuales Destacados (31 con texto):

1. [BAD] - 28/01/2026 16:22 > Escribo de manera confusa, no suma esta seccion sino que confunde

2. [BAD] - 28/01/2026 01:48 > • No corresponden "Seguimiento postquirúrgico y manejo de fístula de LCR, Manejo de convulsiones y evaluación del estado neurológico, Manejo de neumonía y meningitis." • No corresponde "Urología" • Faltan: Neurocirugía, Neurología, Infectología

3. [PARTIAL] - 27/01/2026 21:39 > No es necesaria esta seccion si se aclara en la evolucion

4. [PARTIAL] - 27/01/2026 21:05 > a Cardiología no solo se le interconsultó por el riesgo quirúrgico, asi que aclarar eso está de más

5. [**PARTIAL**] **- 24/01/2026 14:45** > Tiene omisiones porque seguramente lo evaluó infectología, kinesiologia por ej. Excedentes tambien pro que no suma aclarar todo esto en listado cuando ya se conto en la evolución, repite mas de lo mismo.

6. [**PARTIAL**] **- 23/01/2026 23:36** > Solo se deben listar las especialidades médicas intervinientes. En este caso falta neurocirugía (que fue la principal) e infectología (que se sumó en la última complicación infecciosa). "Seguimiento postquirúrgico y manejo de fístula de LCR. • Manejo de convulsiones y evaluación del estado neurológico. • Manejo de neumonía y meningitis." Todo esto no corresponde en esta sección

7. [**PARTIAL**] **- 23/01/2026 12:35** > Cuando no existen interconsultas realizadas se debe aclarar que no las hubo (como en este caso)

8. [**BAD**] **- 22/01/2026 21:55** > no suma aclarar todas las interconsultas de esta manera en una epicrisis

9. [**BAD**] **- 20/01/2026 22:29** > No se aclaran los servicios de las interconsultas! Por ende no se entienden y quedan fuera de contexto los items.

10. [**BAD**] **- 20/01/2026 21:51** > Corresponde poner "Control de infecciones: aislamiento de contacto por tratarse de paciente institucionalizada". Así como está escrito, no se entiende interconsulta o seguimiento por quién o por qué

11. [**BAD**] **- 20/01/2026 20:05** > • No aclaran los servicios! Las interconsultas realizadas por estas paciente son a: Neurología, Neurocirugía, Neurointervencionismo, Infectología, Hematología, Psiquiatría • No se entienden los datos así aislados. Tendría que ponerse, por ejemplo, una interconsulta y lo planteado por ese especialista: "Hematología: anticoagulación con HBPM 60mg/12 hs por trombosis de seno recto. Solicitud de AntiX. Pendiente angiografía digital para completar estudio" u otro ejemplo "Neurocirugía: realización de angioRMN, angiografía digital y eventual biopsia estereotáxica"

12. [**PARTIAL**] **- 20/01/2026 18:50** > La descripcion "• Seguimiento por neumonía asociada a ventilación mecánica por SAMS. Se rota esquema antibiótico AMS x Cefazolina." no implica una especialidad interviniente. Falta la intervención por neurocirugía (quienes son actores fundamentales en este caso)

13. [**BAD**] **- 20/01/2026 02:55** > rin de la fecha no es una ic. es Hematología

14. [**BAD**] **- 20/01/2026 02:28** > valoración por cardiología. no hace falta por que fue porque es redundante con la evolución.

15. [**BAD**] **- 20/01/2026 01:53** > seguimiento? Evaluación y seguimiento por Cirugía de Columna

16. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 22:54** > Se detalla "Estable hemodinámicamente, sin falla cardíaca ni lumbalgia. Iguales indicaciones cardiológicas", lo cuál no es una especialidad médica interviniente. Falta la intervención de cirugía cardiovascular quienes evaluaron la posibilidad de resolución quirúrgica de la endocarditis, luego descartando la misma por estabilidad clínica e imagenológica. El resto de especialidades es correcto

17. [**BAD**] **- 19/01/2026 13:26** > Correcto la interconsulta a Cirugía Plástica. Es incorrecto "Se indica priorizar confort clínico, inicio de morfina + midazolam IV." Eso es una indicación, no un servicio de interconsulta. Corresponde "Cuidados Paliativos"

18. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 00:56** > Se deben nombrar las especialidades intervinientes y opcionalmente algún resumen del motivo de la interconsulta o si hubo un cambio importante de la conducta en relación al motivo de internación. En este caso intervinieron: -Clínica Médica. -Infectología. -Fonoaudiología.

19. [**PARTIAL**] **- 18/01/2026 17:34** > si bien el clinico ve al paciente, y puede considerarse una IC inicial el llamado a cirugía, hecho el diagnóstico es 1 paciente quirúrgico. es de ESE servicio.

20. [**BAD**] **- 17/01/2026 15:50** > Sacarlo, no suma

21. [**BAD**] **- 17/01/2026 15:24** > No repetirlo

22. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 14:46** > Innecesario aclarar.

23. [**BAD**] **- 17/01/2026 14:17** > Ya aclarado previamente no repetir

24. [**BAD**] **- 17/01/2026 13:51** > Sacaría esta sección, ya esta aclarado todo en la evolución y repite lo que aclarado o informado

25. [BAD] - 17/01/2026 13:42 > Solo consignar las especialidades involucradas en un listado, y opcionalmente el motivo de su intervención. En este caso: clínica médica, infectología y fonoaudiología (en este caso importante por disfagia que requirió cambios en la alimentación).

26. [BAD] - 17/01/2026 12:56 > Identificar concretamente las especialidades involucradas y su eventual participación o motivo de intervención. En este caso: clínica médica, infectología y cirugía general

27. [BAD] - 16/01/2026 23:45 > Esta sección no tiene los contenidos que debe tener. Siempre dejar una lista de especialidades intervinientes y se puede agregar un pequeño detalle del motivo de su intervención. En este caso: -Clinica Médica: seguimiento longitudinal. -Infectología: ajuste de tratamiento antibiótico y estudio del síndrome febril. -Urología: descartar conducta quirúrgica por infección urinaria complicada. -Gastroenterología: estudio de alteraciones del hepatograma. Evaluar necesidad de endoscopias.

28. [BAD] - 16/01/2026 18:18 > no sugiere ribaroxaban. Se anticoagula con hbpm y se rota a ribaroxaban al alta

29. [BAD] - 16/01/2026 13:55 > Las interconsultas aquí fueron: Clínica médica, cirugía general y urología. Se deben identificar las especialidades participantes y ponerlas en una lista. Se podría agregar si alguna intervención de interconsulta fue por algún motivo puntual, por ejemplo en este caso urología fue para colocación de sonda vesical por imposibilidad de enfermería y no para evaluación médica por relación del cuadro.

30. [BAD] - 16/01/2026 13:05 > No están bien consignadas las interconsultas, hay repeticiones y datos que no corresponden. En este caso las interconsultas fueron: clínica médica, infectología y urología. Se podría agregar nutrición aunque en este caso particular conviene obviarla dado la irrelevancia de su intervención para el cuadro general.

31. [BAD] - 16/01/2026 12:35 > Este sector no describe lo que tiene que describir, que son las especialidades que formaron parte de la evaluación. En este caso: neurología, neurocirugía y hematología

---

Medicación

Estadísticas: - Total: 47 evaluaciones - OK: 6 | Parcial: 20 | Malo: 21 - Omisiones: 9 | Repeticiones: 15 | Confuso: 20

Feedbacks Individuales (47 registros):

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
1	28/01/2026 16:23	bad	-	Sí	Sí	No es necesario aclarar todos los farmacos y tratamientos instaurados en una epicrisis. Confunde mas de lo que suma
2	28/01/2026 01:51	bad	Sí	Sí	Sí	• No se detallaron los antibióticos utilizados y por qué períodos • No se detallaron los anticomiciales y toda la medicación neurológica que se describe en la historia clínica

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
3	27/01/2026 21:40	bad	-	Sí	Sí	Confuso e innecesario aclarar toda la medicación que recibió durante la internación. Sección que sacaría por completo de la epicrisis.
4	27/01/2026 21:07	bad	-	Sí	Sí	• Se consignan todos los antibióticos usados pero queda confuso. Se debería aclarar las fechas que se usó cada uno como un rango. • Confuso aclarar furosemida, bismuto y potasio, no se utilizaron de f
5	27/01/2026 13:29	partial	-	-	Sí	Deberían ordenarse y clasificarse los fármacos de acuerdo a su importancia y relación con el cuadro actual, y además tener fecha de inicio y finalización de la administración de los mismos
6	27/01/2026 03:33	bad	Sí	Sí	Sí	No esta acenocumarol tiene medicación repetida como el clonazepam ya que esta colocado con nombre generico y comercial. Es importante detectar que es la misma medicación.
7	26/01/2026 17:38	bad	Sí	-	-	Frenulotomía quirúrgica programada

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
8	26/01/2026 17:36	bad	-	Sí	-	no hay indicaciónes al alta que el sistema pueda generar desde la HC.
9	26/01/2026 15:15	bad	-	Sí	Sí	El tratamiento debe enfocarse a la terapeutica mas que a los farmacos utilizados. Listar todo lo que recibió confunde, no informa. Por ejemplo no tiene utilidad mencionar que recibió ringer por unica
10	24/01/2026 14:47	bad	Sí	Sí	Sí	Las drogas que se administran a lo largo de toda una internación y más cuando son prolongadas son MUCHOS y van variado constantemente, aclarar todo el listado hace que sea mas confuso y es un dato inn
11	23/01/2026 23:38	partial	Sí	Sí	Sí	Los farmacos deben estar ordenados por jerarquía en relación al cuadro clínico y con fecha de inicio y finalización de los mismos. En este caso hay dos grupos de farmacos fundamentales: -Antibioticos:
12	23/01/2026 21:26	bad	Sí	Sí	Sí	Frenulotomía es el tratamiento (igual que el procedimiento).

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
13	23/01/2026 13:10	partial	-	-	Sí	Los fármacos listados son correctos. Pero estan desordenados lo que dificulta su interpretación. Se debe distinguir: -Medicación habitual del paciente. -Medicación hospitalaria principal: en este cas
14	23/01/2026 12:36	bad	Sí	-	Sí	Si no se realizas indicaciones médicas al alta se debe dejar explícito "no se realizan indicaciones". En el caso de que consideres que por el cuadro clínico debería irse con alguna indicación, en este
15	23/01/2026 12:30	partial	-	-	Sí	Falta un orden de medicación. En este caso se mezcla el cefepime que fue el antibiótico durante la internación con la levofloxacina y rifampicina que fue la indicación para continuar al alta. Se debe
16	22/01/2026 21:56	bad	-	-	Sí	No es necesaria una sección que aclare los tratamiento recibidos cuando se resume en la evolución
17	22/01/2026 20:38	bad	-	Sí	Sí	No se entiende lo escrito. En este caso no es necesario poner nada en esta sección.

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
18	21/01/2026 12:47	partial	-	Sí	Sí	lo de la Sol Fisiologica variable continuo que figure el fluconazol como unica vez está ok sobra el “No renueva”
19	20/01/2026 22:31	bad	Sí	Sí	Sí	Debería consignarse su medicación habitual (que permanece igual sin modificaciones luego de la internación), sumado a lo que se agregue (analgesia y tromboprofilaxis)
20	20/01/2026 21:52	bad	-	Sí	Sí	Consignaría la medicación habitual o la sedación paliativa utilizada y nada más
21	20/01/2026 21:20	ok	-	-	-	-
22	20/01/2026 20:06	bad	-	Sí	Sí	Es confuso, ya que se interpreta que es la medicación con la que la paciente deberia egresar. En este caso se va de alta voluntaria, por ende indicaría su medicación habitual (suspendiendo aspirina) y
23	20/01/2026 18:51	partial	Sí	-	Sí	Siempre aclarar la medicación principal con fecha de inicio y finalización de administración. En este caso falta la administración de fenitoina y midazolam, que si bien fue transitoria, fue parte impo

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
24	20/01/2026 02:56	ok	-	-	-	-
25	20/01/2026 02:27	ok	-	-	-	-
26	20/01/2026 01:55	ok	-	-	-	-
27	19/01/2026 22:57	partial	-	-	-	El listado de medicamentos es correcto. Se deben clasificar en: -Medicación habitual: es la que viene realizando el paciente previamente. Puede obviarse en caso de no ser relevante para el cuadro actu
28	19/01/2026 15:09	ok	-	-	-	-
29	19/01/2026 13:26	partial	-	-	-	Agregar en los antibióticos las fecha de inicio y fin de los mismos
30	19/01/2026 01:01	partial	-	-	-	Los medicamentos son correctos pero estan desorganizados, lo que hace dificultosa su lectura e interpretación. Se deben organizar en grupos según su importancia al caso actual e incluir presentación,
31	19/01/2026 00:40	partial	-	-	-	Apixaban fue una medicación al alta, no se realizó en internación. El resto es correcto pero deben organizarse en fármacos principales con dosis, fecha de inicio y finalización. Y los farmacos secund

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
32	19/01/2026 00:30	partial	-	-	-	Apixaban era una medicación al alta, no se realizó durante la internación. El resto está correcto pero debe ordenarse y jerarquizarse, y además aclarar los días de realización o fecha de inicio y fin
33	18/01/2026 17:26	partial	-	-	-	el tramadol se discontinua por somnoliencia. se pasa a ketorolac, no se administran ambos en simultaneo. es 1 sustitución
34	17/01/2026 15:51	bad	-	-	-	Se puede aclarar en evolución que recibió tratamiento con proquinéticos y eso sería suficiente. No nos cambia a los médicos saber estos detalles a la hora de leer una epicrisis.
35	17/01/2026 15:25	bad	-	-	-	No lo aclararía, no suma en la epicrisis esto
36	17/01/2026 14:46	bad	-	-	-	Repite cosas ya expuestas, borraría todo lo aclarado en esta sección.
37	17/01/2026 14:21	partial	-	-	-	El tratamiento terapéutico se aclara durante la explicación de lo que se fue interpretando del paciente no lo aclararía nuevamente

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
38	17/01/2026 14:19	partial	-	-	-	Error importante: se puso en indicaciones un tratamiento que tuvo durante internación eso no puede suceder (• Solución Ringer Lactato · 1500ml · Intravenoso · Goteo continuo; Potasio Cloruro 3 ampolla
39	17/01/2026 13:52	partial	-	-	-	Para el paciente es importante aclararle cuales con los medicamentos que son nuevos o diferentes a los que tomada previamente, haría una distinción respecto a eso.
40	17/01/2026 12:58	partial	-	-	-	La hidratación parenteral no incluirla salvo que tenga relación con el cuadro principal, por ejemplo: utilización de fluidos parenterales para resucitación o redistribu-ció/corrección hidroelectrolític
41	16/01/2026 23:47	partial	-	-	-	La medicación debe estar ordenada, aclarar los días totales de administración, priorizar la medicación más relevante con el caso, en el caso de la hidratación parenteral conviene no incluirla salvo qu

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
42	16/01/2026 18:18	bad	-	-	-	debe colocarse el tiempo de antibiotico. en este paciente fueron 24hs.
43	16/01/2026 13:57	partial	-	-	-	Diferenciar y clasificar: medicación habitual del paciente (repuesta en internación), medicación hospitalaria principal (en este caso los antibióticos y analgésicos, consignando ademas de la dosis, lo
44	16/01/2026 13:06	partial	-	-	-	Los farmacos administrados están bien. Conviene jerarquizar y ordenar a los mismos en: medicación habitual (la que realiza el paciente y se repone en internación), medicación hospitalaria principal (e
45	16/01/2026 12:37	partial	-	-	-	Aquí debe diferenciarse: medicación habitual del paciente (es la que se consigna al ingreso y se repone en la internación), medicación hospitalaria principal (es la que se relaciona con el cuadro clín
46	16/01/2026 04:43	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
47	16/01/2026 04:19	bad	-	-	-	Ceftriaxona 1000mg debe decir: completó 7 días. - Es importante para el paciente y otro medico que el tratamiento fue completo. Insulina rapida no hace falta en este caso colocar 1u. puede colocarse:

Comentarios Textuales Destacados (41 con texto):

1. [BAD] - 28/01/2026 16:23 > No es necesario aclarar todos los farmacos y tratamientos instaurados en una epicrisis. Confunde mas de lo que suma

2. [BAD] - 28/01/2026 01:51 > • No se detallaron los antibióticos utilizados y por qué períodos • No se detallaron los anticomiciales y toda la medicación neurológica que se describe en la historia clínica

3. [BAD] - 27/01/2026 21:40 > Confuso e innecesario aclarar toda la medicación que recibió durante la internación. Sección que sacaría por completo de la epicrisis.

4. [BAD] - 27/01/2026 21:07 > • Se consignan todos los antibióticos usados pero queda confuso. Se debería aclarar las fechas que se usó cada uno como un rango. • Confuso aclarar furosemida, bismuto y potasio, no se utilizaron de forma permanente o continua

5. [PARTIAL] - 27/01/2026 13:29 > Deberían ordenarse y clasificarse los fármacos de acuerdo a su importancia y relación con el cuadro actual, y además tener fecha de inicio y finalización de la administración de los mismos

6. [BAD] - 27/01/2026 03:33 > No esta acenocumarol tiene medicación repetida como el clonazepam ya que esta colocado con nombre generico y comercial. Es importante detectar que es la misma medicación.

7. [BAD] - 26/01/2026 17:38 > Frenulotomía quirúrgica programada

8. [BAD] - 26/01/2026 17:36 > no hay indicaciónes al alta que el sistema pueda generar desde la HC.

9. [BAD] - 26/01/2026 15:15 > El tratamiento debe enfocarse a la terapeutica mas que a los farmacos utilizados. Listar todo lo que recibió confunde, no informa. Por ejemplo no tiene utilidad mencionar que recibió ringer por unica vez. Tampoco tiene sentido contar todos los analgesicos que recibió. Con mencionar tratamiento analgesico en titulación es suficiente.

10. [BAD] - 24/01/2026 14:47 > Las drogas que se administran a lo largo de toda una internación y más cuando son prolongadas son MUCHOS y van variado constantemente, aclarar todo el listado hace que sea mas confuso y es un dato innecesario para la compresión de su internación. Por lo tanto si bien me parece una sección innecesaria y la sacaría completamente si sigue estando pondría por ejemplo todos los antibióticos que recibió.

11. [PARTIAL] - 23/01/2026 23:38 > Los farmacos deben estar ordenados por jerarquía en relación al cuadro clínico y con fecha de inicio y finalización de los mismos. En este caso hay dos grupos de farmacos fundamentales: -Antibioticos: se debe explicitar que se hizo dos cursos de ampicilina-sulbactam y en el último episodio hizo vancomicina, meropenem y colistin. -Anticonvulsivantes: falta fenobarbital y fenitoina.

12. [BAD] - 23/01/2026 21:26 > Frenulotomía es el tratamiento (igual que el procedimiento).

13. [PARTIAL] - 23/01/2026 13:10 > Los fármacos listados son correctos. Pero estan desordenados lo que dificulta su interpretación. Se debe distinguir: -Medicación habitual del paciente. -Medicación hospitalaria principal: en este caso los antibióticos con fecha de inicio y finalización. -Medicación hospitalaria complementarias: única dosis, anexos, analgésicos.

14. [**BAD**] **- 23/01/2026 12:36** > Si no se realizas indicaciones médicas al alta se debe dejar explícito "no se realizan indicaciones". En el caso de que consideres que por el cuadro clínico debería irse con alguna indicación, en este caso podría ser analgesia con AINE, podes incluirlo como sugerencia

15. [**PARTIAL**] **- 23/01/2026 12:30** > Falta un orden de medicación. En este caso se mezcla el cefepime que fue el antibiótico durante la internación con la levofloxacina y rifampicina que fue la indicación para continuar al alta. Se deben clasificar los fármacos de acuerdo a su importancia y poner fecha de inicio y finalización

16. [**BAD**] **- 22/01/2026 21:56** > No es necesaria una sección que aclare los tratamiento recibidos cuando se resume en la evolución

17. [**BAD**] **- 22/01/2026 20:38** > No se entiende lo escrito. En este caso no es necesario poner nada en esta sección.

18. [**PARTIAL**] **- 21/01/2026 12:47** > lo de la Sol Fisiologica variable continuo que figure el fluconazol como unica vez está ok sobra el "No renueva"

19. [**BAD**] **- 20/01/2026 22:31** > Debería consignarse su medicación habitual (que permanece igual sin modificaciones luego de la internación), sumado a lo que se agregue (analgesia y tromboprofilaxis)

20. [**BAD**] **- 20/01/2026 21:52** > Consignaría la medicación habitual o la sedación paliativa utilizada y nada más

21. [**BAD**] **- 20/01/2026 20:06** > Es confuso, ya que se interpreta que es la medicación con la que la paciente deberia egresar. En este caso se va de alta voluntaria, por ende indicaría su medicación habitual (suspendiendo aspirina) y recomendando anticoagulación con enoxaparina 60 mg/12 hs y corticoterapia con dexametasona hasta completar estudios diagnósticos e iniciar eventual tratamiento.

22. [**PARTIAL**] **- 20/01/2026 18:51** > Siempre aclarar la medicación principal con fecha de inicio y finalización de administración. En este caso falta la administración de fenitoina y midazolam, que si bien fue transitoria, fue parte importante de la evolución

23. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 22:57** > El listado de medicamentos es correcto. Se deben clasificar en: -Medicación habitual: es la que viene realizando el paciente previamente. Puede obviarse en caso de no ser relevante para el cuadro actual. -Medicación hospitalaria principal: en este caso dado que es un cuadro infeccioso es fundamental detallar los antibióticos, cada uno con fecha de inicio y finalización. -Medicación hospitalaria secundaria: la que no está relacionada con el cuadro actual o es única dosis/rescate. La medicación al alta (en este caso warfarina) debe detallarse en el sector correspondiente

24. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 13:26** > Agregar en los antibióticos las fecha de inicio y fin de los mismos

25. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 01:01** > Los medicamentos son correctos pero estan desorganizados, lo que hace dificultosa su lectura e interpretación. Se deben organizar en grupos según su importancia al caso actual e incluir presentación, posología y DIAS DE ADMINISTRACION (o fecha de inicio y finalización). Corresponde diferenciar: -Medicación habitual del paciente: la que realizaba previamente. -Medicación hospitalaria principal: en este caso los antibióticos y el ácido fólico porque tienen mucha relación con el cuadro clínico y el desarrollo de internación. -Medicación hospitalaria secundaria: tópica, nebulizables, únicas dosis o rescates medicamentosos.

26. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 00:40** > Apixaban fue una medicación al alta, no se realizó en internación. El resto es correcto pero deben organizarse en fármacos principales con dosis, fecha de inicio y finalización. Y los farmacos secundarios (que no tienen mucha relevancia con el cuadro actual) como unica dosis, nebulizables, adyuvantes, solo nombrarlos.

27. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 00:30** > Apixaban era una medicación al alta, no se realizó durante la internación. El resto está correcto pero debe ordenarse y jerarquizarse, y además aclarar los días de realización o fecha de inicio y fin de administración, sobretodo de los fármacos importantes para la enfermedad actual. Los farmacos única dosis, nebulizables, y adyuvantes pueden solo nombrarse.

28. [**PARTIAL**] **- 18/01/2026 17:26** > el tramadol se discontinua por somnoliencia. se pasa a ketorolac, no se administran ambos en simultaneo. es 1 sustitución

29. [**BAD**] **- 17/01/2026 15:51** > Se puede aclarar en evolución que recibió tratamiento con proquinéticos y eso sería suficiente. No nos cambia a los médicos saber estos detalles a la hora de leer una epicrisis.

30. [**BAD**] **- 17/01/2026 15:25** > No lo aclararía, no suma en la epicrisis esto

31. [**BAD**] **- 17/01/2026 14:46** > Repite cosas ya expuestas, borraría todo lo aclarado en esta sección.

32. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 14:21** > El tratamiento terapéutico se aclara durante la explicación de lo que se fue interpretando del paciente no lo aclararía nuevamente

33. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 14:19** > Error importante: se puso en indicaciones un tratamiento que tuvo durante internación eso no puede suceder (• Solución Ringer Lactato · 1500ml · Intravenoso · Goteo continuo; Potasio Cloruro 3 ampollas; Magnesio Sulfato 3g). Aclarar medicación nueva y HASTA CUANDO

34. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 13:52** > Para el paciente es importante aclararle cuales con los medicamentos que son nuevos o diferentes a los que tomada previamente, haría una distinción respecto a eso.

35. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 12:58** > La hidratación parenteral no incluirla salvo que tenga relación con el cuadro principal, por ejemplo: utilización de fluidos parenterales para resucitación o redistribució/corrección hidroelectrolítica. Los fármacos única dosis (secundarios) podrían agruparse y simplificar su detalle al nombre genérico y dosis. Destacar los farmacos principales, en este caso la antibióticoterapia por ser un cuadro con sospecha de infección

36. [**PARTIAL**] **- 16/01/2026 23:47** > La medicación debe estar ordenada, aclarar los días totales de administración, priorizar la medicación más relevante con el caso, en el caso de la hidratación parenteral conviene no incluirla salvo que sea importante para el cuadro (ejemplo: sepsis que requirió expansion con solucion fisiologica, trastornos hidroelectroliticos, insuficiencia renal pre-renal)

37. [**BAD**] **- 16/01/2026 18:18** > debe colocarse el tiempo de antibiotico. en este paciente fueron 24hs.

38. [**PARTIAL**] **- 16/01/2026 13:57** > Diferenciar y clasificar: medicación habitual del paciente (repuesta en internación), medicación hospitalaria principal (en este caso los antibióticos y analgésicos, consignando ademas de la dosis, los días o rango de fechas en que se realizaron), y la medicación hospitalaria secundaria (unica dosis, rescates, pocas dosis, no relacionadas con el cuadro). Esto es de valor para comprender cuáles de los tratamientos farmacológicos están relacionados al cuadro actual y formaron parte de la internvención, cuáles ya los realiza el paciente y cuáles son de menor jerarquía y solo debiesen tenerse en cuenta para analisis secundario (efectos adversos, intolerancia, por ejemplo)

39. [**PARTIAL**] **- 16/01/2026 13:06** > Los farmacos administrados están bien. Conviene jerarquizar y ordenar a los mismos en: medicación habitual (la que realiza el paciente y se repone en internación), medicación hospitalaria principal (en este caso los antibióticos, aclarando además de las dosis, las fechas en las cuales se realizaron o los días totales de administración), y medicación hospitalaria anexa (pocas dosis, única dosis, o que no tienen relevancia en el cuadro clínico actual).

40. [**PARTIAL**] **- 16/01/2026 12:37** > Aquí debe diferenciarse: medicación habitual del paciente (es la que se consigna al ingreso y se repone en la internación), medicación hospitalaria principal (es la que se relaciona con el cuadro clínico, como la nitroglicerina por la HTA secundaria a la hemorragia intraparenquimatosa cerebral) y la medicación hospitalaria ocasional/unica o pocas dosis, como las correcciones de insulina, etc

41. [**BAD**] **- 16/01/2026 04:19** > Ceftriaxona 1000mg debe decir: completó 7 días. - Es importante para el paciente y otro medico que el tratamiento fue completo.

Insulina rapida no hace falta en este caso colocar 1u. puede colocarse: correcciónes con insulina rapida.

Indicaciones de Alta

Estadísticas: - Total: 52 evaluaciones - OK: 23 | Parcial: 19 | Malo: 10 - Omisiones: 9 | Repeticiones: 0 | Confuso: 3

Feedbacks Individuales (52 registros):

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
1	28/01/2026 16:24	bad	Sí	-	-	Tiene que estar indicado la dosis proxima de rituximab que quedo pendiente y la aplicacion de vacunas. Tampoco esta la medicación al alta con la que egresa ej: corticoides.
2	28/01/2026 01:51	ok	-	-	-	-
3	28/01/2026 01:51	ok	-	-	-	-
4	27/01/2026 21:41	partial	-	-	-	En la sección de evolución o en alguna de estas HAY QUE ALCARAR EL HORARIO DEL OBITO
5	27/01/2026 21:08	partial	Sí	-	-	Falta aclarar el resto de la medicación al alta de forma clara.
6	27/01/2026 13:29	ok	-	-	-	-
7	27/01/2026 03:34	bad	Sí	-	-	Falta el plan farmacologico El contro con electrofisiología tiene tiempos precisos
8	26/01/2026 17:38	partial	Sí	-	-	consultorio de quien? y en que fecha
9	26/01/2026 16:09	ok	-	-	-	-
10	24/01/2026 14:48	ok	-	-	-	-
11	24/01/2026 14:48	ok	-	-	-	-
12	23/01/2026 23:38	ok	-	-	-	-
13	23/01/2026 21:28	partial	Sí	-	-	Faltan aclarar indicaciones farmacológicas (analgésicos, de requerirse)

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
14	23/01/2026 21:27	partial	Sí	-	-	Faltan aclarar indicaciones al alta, como por ejemplo analgésicos (de requerirse), actividades sexual permitida e higienización, etc.
15	23/01/2026 13:11	partial	Sí	-	-	Falta describir los cuidados que deben tenerse con el sistema de vacío continuo
16	23/01/2026 12:30	ok	-	-	-	-
17	22/01/2026 21:56	partial	Sí	-	-	aclarar dosis de antibiótico a recibir por ambulatorio
18	22/01/2026 20:39	partial	Sí	-	-	Posterior a una cirugía siempre es importante aclarar en caso de dolor que puede tomar el paciente y la posología. En lo posible aclarar qué día y horario tiene el control con el cirujano por consult
19	21/01/2026 12:55	partial	-	-	Sí	la paciente se externa en régimen de cuidados domiciliarios paliativos (fin de vida) con seguimiento por medico de CP. está ok que quede explicitado. lo de la IC con nutrición está ok , lo de que s
20	20/01/2026 22:32	partial	-	-	Sí	Debería aclararse la medicación en la sección anterior. Falta información respecto al turno de seguimiento ambulatorio, y especialidad

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
21	20/01/2026 21:52	ok	-	-	-	-
22	20/01/2026 21:20	ok	-	-	-	-
23	20/01/2026 20:07	partial	-	-	Sí	Están bien realizadas las sugerencias. Lo que es confuso, es que esta paciente por la patología que tiene y haber solicitado el alta voluntaria, debería continuar sus estudios en un contexto de intern
24	20/01/2026 18:51	ok	-	-	-	-
25	20/01/2026 02:57	bad	-	-	-	falta la medicación del alta. El tratamiento terapeutico tiene medicación que se utilizo pero que se suspendió antes del alta como la hidroclorotiazida. Un paciente debe tener el plan terapéutico comp
26	20/01/2026 02:27	ok	-	-	-	-
27	20/01/2026 02:26	partial	-	-	-	el corticoide y el tappering no esta correctamente colocado.
28	20/01/2026 02:26	ok	-	-	-	-
29	20/01/2026 01:53	bad	-	-	-	Esta la indicación del corset por el traumatologo.
30	19/01/2026 22:59	partial	-	-	-	“Se solicita medicación para continuar tratamiento antibiótico prolongado EV y oral en domicilio” no constituye una indicación al alta. Los antibióticos deben detallarse droga, dosis y duración del tr

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
31	19/01/2026 15:09	bad	-	-	-	seguimiento por urología no es una indicación. El paciente no suspende ceftriaxona, sino que se rota a Amoxicilina al alta. Debe constar un plan de alta completo de medicación al alta. Es importante
32	19/01/2026 13:26	ok	-	-	-	-
33	19/01/2026 01:01	ok	-	-	-	-
34	19/01/2026 00:40	ok	-	-	-	-
35	19/01/2026 00:30	ok	-	-	-	-
36	18/01/2026 17:36	partial	-	-	-	la estrategia de evacuación debe estar clara y priorizada. procurar diariamente, como manejar si no ocurre esto debe explicitarse
37	18/01/2026 17:24	partial	-	-	-	incompleta - falta la estatina
38	17/01/2026 15:53	partial	-	-	-	• Asegurar tránsito intestinal diario (lo pondría en forma de pautas de alarma ej: si catarsis negativa por “X” cantidad de tiempo , dolor abdominal o vómitos persistentes consultar a guardia) Sacaría
39	17/01/2026 15:26	partial	-	-	-	control de signos vitales y diuresis no es una indicación para un paciente, hay que sacarlo

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
40	17/01/2026 14:48	partial	-	-	-	en la epicrisis siempre es importante aclarar que fue un óbito y el horario en que se constató, sea en esta sección o en donde se considere. Ejemplo al final de la evolución.
41	17/01/2026 14:21	ok	-	-	-	-
42	17/01/2026 12:59	bad	-	-	-	Lo más importante fue que existió la sospeccha de una infección de sitio quirúrgico superficial, por lo que realizó tratamiento antibiótico endovenoso y debe continuar con tratamiento antibiótico vía
43	16/01/2026 23:47	ok	-	-	-	-
44	16/01/2026 18:18	ok	-	-	-	-
45	16/01/2026 14:01	partial	-	-	-	Se debe aclarar en caso de farmacos el nombre genérico, posología y días. Siempre con exactitud, y no dejarlo a cargo del paciente. Elegirlo según cuadro clínico y farmacos realizados.
46	16/01/2026 13:57	ok	-	-	-	-
47	16/01/2026 13:07	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
48	16/01/2026 12:39	bad	-	-	-	Este sector deberia incluir el tratamiento farmacológico sugerido al momento de externarse y algunas otras recomendaciones terapéuticas no farmacológicas, como la dieta. Tener cuidado con la actividad
49	16/01/2026 04:43	bad	-	-	-	Mantener hidratación oral NOOOOOO!!! Este paciente se mantuvo hidratación oral en la internación, pero su cuadro es por exceso de liquido. La recomendación es la restricción y limitación de hidratació
50	16/01/2026 04:22	bad	-	-	-	Falta indicaciónes del tratamiento del dolor que ha recibido. En la HC no esta detallado asi que no lo puede inventar. No obstante si falta la IC de columna donde esta la recomendación de utilización
51	16/01/2026 04:19	ok	-	-	-	-
52	15/01/2026 13:54	bad	-	-	-	Le dejo anticoagulante, pero no lo detalla correctamente en la hc

Comentarios Textuales Destacados (29 con texto):

1. [BAD] - 28/01/2026 16:24 > Tiene que estar indicado la dosis proxima de rituximab que quedo pendiente y la aplicacion de vacunas. Tampoco esta la medicación al alta con la que egresa ej: corticoides.

2. [PARTIAL] - 27/01/2026 21:41 > En la sección de evolución o en alguna de estas HAY QUE ALCARAR EL HORARIO DEL OBITO

3. [**PARTIAL**] **- 27/01/2026 21:08** > Falta aclarar el resto de la medicación al alta de forma clara.

4. [**BAD**] **- 27/01/2026 03:34** > Falta el plan farmacologico El contro con electrofisiología tiene tiempos precisos

5. [**PARTIAL**] **- 26/01/2026 17:38** > consultorio de quien? y en que fecha

6. [**PARTIAL**] **- 23/01/2026 21:28** > Faltan aclarar indicaciones farmacológicas (analgésicos, de requerirse)

7. [**PARTIAL**] **- 23/01/2026 21:27** > Faltan aclarar indicaciones al alta, como por ejemplo analgésicos (de requerirse), actividades sexual permitida e higienización, etc.

8. [**PARTIAL**] **- 23/01/2026 13:11** > Falta describir los cuidados que deben tenerse con el sistema de vacío continuo

9. [**PARTIAL**] **- 22/01/2026 21:56** > aclarar dosis de antibiótico a recibir por ambulatorio

10. [**PARTIAL**] **- 22/01/2026 20:39** > Posterior a una cirugía siempre es importante aclarar en caso de dolor que puede tomar el paciente y la posología. En lo posible aclarar qué día y horario tiene el control con el cirujano por consultorio.

11. [**PARTIAL**] **- 21/01/2026 12:55** > la paciente se externa en régimen de cuidados domiciliarios paliativos (fin de vida) con seguimiento por medico de CP. está ok que quede explicitado. lo de la IC con nutrición está ok , lo de que sea via whatsapp no debería estar ahi

12. [**PARTIAL**] **- 20/01/2026 22:32** > Debería aclararse la medicación en la sección anterior. Falta información respecto al turno de seguimiento ambulatorio, y especialidad

13. [**PARTIAL**] **- 20/01/2026 20:07** > Están bien realizadas las sugerencias. Lo que es confuso, es que esta paciente por la patología que tiene y haber solicitado el alta voluntaria, debería continuar sus estudios en un contexto de internación, no en ambulatorio.

14. [**BAD**] **- 20/01/2026 02:57** > falta la medicación del alta. El tratamiento terapeutico tiene medicación que se utilizo pero que se suspendió antes del alta como la hidroclorotiazida. Un paciente debe tener el plan terapéutico completo y detallado.

15. [**PARTIAL**] **- 20/01/2026 02:26** > el corticoide y el tappering no esta correctamente colocado.

16. [**BAD**] **- 20/01/2026 01:53** > Esta la indicación del corset por el traumatologo.

17. [**PARTIAL**] **- 19/01/2026 22:59** > "Se solicita medicación para continuar tratamiento antibiótico prolongado EV y oral en domicilio" no constituye una indicación al alta. Los antibióticos deben detallarse droga, dosis y duración del tratamiento. En cuanto a la anticoagulación debe detallarse la dosis de warfarina.

18. [**BAD**] **- 19/01/2026 15:09** > seguimiento por urología no es una indicación. El paciente no suspende ceftriaxona, sino que se rota a Amoxicilina al alta.

Debe constar un plan de alta completo de medicación al alta. Es importante para evitar errores de indicación.

Al mismo tiempo debe tener indicaciónes dietarias claras y de ingesta de liquido.

19. [**PARTIAL**] **- 18/01/2026 17:36** > la estrategia de evacuación debe estar clara y priorizada. procurar diariamente, como manejar si no ocurre esto debe explicitarse

20. [**PARTIAL**] **- 18/01/2026 17:24** > incompleta - falta la estatina

21. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 15:53** > • Asegurar tránsito intestinal diario (lo pondría en forma de pautas de alarma ej: si catarsis negativa por "X" cantidad de tiempo , dolor abdominal o vómitos persistentes consultar a guardia) Sacaría la siguiente indicación: • En caso de constipación, lactulosa 10ml con almuerzo y cena (puede aumentarse a desayuno, almuerzo, merienda y cena). Ya que una paciente con suboclusión intestinal no va de cuerpo por un problema mecánico, no por problemas en la motilidad intestinal, por lo cual no sería el tratamiento correspondiente.

22. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 15:26** > control de signos vitales y diuresis no es una indicación para un paciente, hay que sacarlo

23. [**PARTIAL**] **- 17/01/2026 14:48** > en la epicrisis siempre es importante aclarar que fue un óbito y el horario en que se constató, sea en esta sección o en donde se considere. Ejemplo al final de la evolución.

24. **[BAD] - 17/01/2026 12:59** > Lo más importante fue que existió la sospeccha de una infección de sitio quirúrgico superficial, por lo que realizó tratamiento antibiótico endovenoso y debe continuar con tratamiento antibiótico vía oral (AMC). Siempre identificar los fármacos más importantes en relación al cuadro clínico y cuáles de ellos se deben seguir al alta. En el caso de que no estén aclarados, podrías sugerirlo.

25. **[PARTIAL] - 16/01/2026 14:01** > Se debe aclarar en caso de farmacos el nombre genérico, posología y días. Siempre con exactitud, y no dejarlo a cargo del paciente. Elegirlo según cuadro clínico y farmacos realizados.

26. **[BAD] - 16/01/2026 12:39** > Este sector deberia incluir el tratamiento farmacológico sugerido al momento de externarse y algunas otras recomendaciones terapéuticas no farmacológicas, como la dieta. Tener cuidado con la actividad física, que es importante en un paciente con riesgo cardiovascular pero en este caso inmediatamente posterior a un ACV hemorrágico no es lo más recomendable.

27. **[BAD] - 16/01/2026 04:43** > Mantener hidratación oral NOOOOOO!!! Este paciente se mantuvo hidratación oral en la internación, pero su cuadro es por exceso de liquido. La recomendación es la restricción y limitación de hidratación.

28. **[BAD] - 16/01/2026 04:22** > Falta indicaciónes del tratamiento del dolor que ha recibido. En la HC no esta detallado asi que no lo puede inventar. No obstante si falta la IC de columna donde esta la recomendación de utilización de corset

29. **[BAD] - 15/01/2026 13:54** > Le dejo anticoagulante, pero no lo detalla correctamente en la hc

---

Recomendaciones

Estadísticas: - Total: 45 evaluaciones - OK: 19 | Parcial: 17 | Malo: 9 - Omisiones: 6 | Repeticiones: 5 | Confuso: 8

Feedbacks Individuales (45 registros):

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
1	28/01/2026 16:24	ok	-	-	-	-
2	28/01/2026 01:51	ok	-	-	-	-
3	27/01/2026 21:10	bad	-	Sí	Sí	Los últimos dos items corresponderian a la seccion de recomendaciones. Cuando se trata de indicaciones farmacológicas, deberia ir en la sección “indicaciones al alta”
4	27/01/2026 13:29	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
5	27/01/2026 03:35	bad	-	Sí	Sí	Continuar tratamiento farmacologico? cual si no esta en la epicrisis. no se solicita ACO! se suspendió el acenocumarol por sangrado! Eso quedó inactivo por la complicación posterior.
6	26/01/2026 17:38	bad	Sí	-	-	Deberia tener pautas de alarma estandares para este pop
7	26/01/2026 16:10	bad	-	Sí	Sí	Paciente fallece = No hay recomendaciones ni indicaciónes de alta!
8	24/01/2026 14:48	ok	-	-	-	-
9	24/01/2026 14:48	ok	-	-	-	-
10	23/01/2026 23:38	ok	-	-	-	-
11	23/01/2026 21:28	bad	Sí	-	-	En esta sección deberían indicarse las pautas postoperatorias de la frenulectomía
12	23/01/2026 13:12	bad	Sí	-	Sí	No debe indicarse hielo en la herida dado que tiene un sistema de vacío continuo que imposibilita esa práctica. Debe aclararse la importancia del control con hematología dado que es imprescindible mon

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
13	23/01/2026 12:36	bad	Sí	-	Sí	En caso de cirugía se deben indicar los cuidados postquirúrgicos siempres. Nunca deben faltar las pautas de alarma para consulta en lenguaje que el paciente comprenda
14	23/01/2026 12:30	partial	Sí	-	-	Faltan las pautas de alarma para reconsultar en un lenguaje entendible para el paciente
15	22/01/2026 21:58	partial	-	-	-	EN esta sección o en tratamiento al alta es importante aclarar que el paciente se va con INTERNACIÓN DOMICILIARIA y aclarar cuales fueron los pedidos solicitados a la prepaga. Se esta manera el famil
16	22/01/2026 20:39	ok	-	-	-	-
17	21/01/2026 13:04	bad	-	Sí	Sí	lo que es inherente a las indicaciones medicas al alta debe estar arriba. puede haber algun tip (dejar media hora entre la toma de levotiroxina y otros remedios o desayuno) pero aparecen analgesicos
18	20/01/2026 22:32	ok	-	-	-	-
19	20/01/2026 21:52	ok	-	-	-	-
20	20/01/2026 21:20	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
21	20/01/2026 20:09	partial	-	-	Sí	La recomendación principal sería: continuar estudios diagnósticos en centro apropiado, en contexto de internación. Eso sería lo correcto, aunque la paciente solicitó el egreso voluntario (contra suger
22	20/01/2026 18:52	partial	Sí	Sí	Sí	" Traslado en ambulancia con médico acompañante a centro de rehabilitación cercano al domicilio." no es una recomendación al alta ya que se fue con internación domiciliaria. Falta la indicación de reh
23	20/01/2026 02:57	ok	-	-	-	-
24	20/01/2026 02:26	ok	-	-	-	-
25	20/01/2026 01:55	bad	-	-	-	rehabilitar no dice en la HC.
26	19/01/2026 23:00	partial	-	-	-	Uno de los motivos de persistencia de la internación fue la falla renal, y una de las condiciones para la externación con internación domiciliaria fue la posibilidad de control analítico de la misma c
27	19/01/2026 13:26	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
28	19/01/2026 01:02	partial	-	-	-	Especificar las indicaciones de fonoaudiología. Siempre incluir las pautas de alarma para reconsulta en un lenguaje claro para el paciente
29	19/01/2026 00:40	partial	-	-	-	Siempre aclarar pautas de alarma con lenguaje que entienda el paciente
30	19/01/2026 00:31	partial	-	-	-	Siempre especificar pautas de alarma para reconsulta en un lenguaje claro para el paciente.
31	18/01/2026 17:28	partial	-	-	-	en la indicación / recomendación de alta NO va que en la internación se suspendió un medicamento, que además debe recomenzar.
32	17/01/2026 15:53	partial	-	-	-	Sería importante aclararle en el a epicrisis cuando tiene que ver al cirujano para que la controle
33	17/01/2026 15:26	ok	-	-	-	-
34	17/01/2026 14:48	ok	-	-	-	-
35	17/01/2026 14:22	partial	-	-	-	Agregaría pautas de alarma. Ej.: si presenta nuevamente sangrado, diarrea persistente, confusión, etc consultar a guardia.
36	17/01/2026 13:53	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
37	17/01/2026 13:00	partial	-	-	-	Detallar específicamente qué pautas de alarma se deben tener en cuenta en base al cuadro clínico y redactarlas en un lenguaje que entienda el paciente
38	16/01/2026 23:48	partial	-	-	-	Siempre incluir pautas de alarma. En este caso tener en cuenta que la paciente se va de alta voluntaria, lo que aumenta notablemente los riesgos de mala evolución. Esto tiene que estar aclarado explíc
39	16/01/2026 18:19	ok	-	-	-	-
40	16/01/2026 13:57	partial	-	-	-	Siempre deben agregarse las pautas de alarma para reconsulta en lenguaje claro para que el paciente pueda interpetarlas en su domicilio y eventualmente reconsultar
41	16/01/2026 13:07	partial	-	-	-	Debería incluir cuidados de la sonda, dado que es un dispositivo cuyas complicaciones pueden generar una internación (como en este caso), y además las pautas de alarma para la reconsulta con un lengua
42	16/01/2026 12:37	ok	-	-	-	-

#	Fecha	Rating	Omisiones	Repeticiones	Confuso	Comentario
43	16/01/2026 04:44	partial	-	-	-	Disnea cambiar por falta de aire. - Las recomendaciónes al paciente debe evitar el lenguaje médico.
44	16/01/2026 04:23	partial	-	-	-	no tiene indicación de dieta blanda. No tiene como inventarlo asi que no es problema del sistema, sino de registro.
45	15/01/2026 13:54	ok	-	-	-	-

Comentarios Textuales Destacados (26 con texto):

1. [BAD] - 27/01/2026 21:10 > Los últimos dos items corresponderian a la seccion de recomendaciones. Cuando se trata de indicaciones farmacológicas, deberia ir en la sección "indicaciones al alta"

2. [BAD] - 27/01/2026 03:35 > Continuar tratamiento farmacologico? cual si no esta en la epicrisis. no se solicita ACO! se suspendió el acenocumarol por sangrado! Eso quedó inactivo por la complicación posterior.

3. [BAD] - 26/01/2026 17:38 > Deberia tener pautas de alarma estandares para este pop

4. [BAD] - 26/01/2026 16:10 > Paciente fallece = No hay recomendaciones ni indicaciónes de alta!

5. [BAD] - 23/01/2026 21:28 > En esta sección deberían indicarse las pautas postoperatorias de la frenulectomía

6. [BAD] - 23/01/2026 13:12 > No debe indicarse hielo en la herida dado que tiene un sistema de vacío continuo que imposibilita esa práctica. Debe aclararse la importancia del control con hematología dado que es imprescindible monitorizar como seguir con la anticoagulación. Faltan las pautas de alarma para la consulta del paciente.

7. [BAD] - 23/01/2026 12:36 > En caso de cirugía se deben indicar los cuidados postquirúrgicos siempres. Nunca deben faltar las pautas de alarma para consulta en lenguaje que el paciente comprenda

8. [PARTIAL] - 23/01/2026 12:30 > Faltan las pautas de alarma para reconsultar en un lenguaje entendible para el paciente

9. [PARTIAL] - 22/01/2026 21:58 > EN esta sección o en tratamiento al alta es importante aclarar que el paciente se va con INTERNACIÓN DOMICILIARIA y aclarar cuales fueron los pedidos solicitados a la prepaga. Se esta manera el familiar o paciente saben que les corresponde esperar en domicilio según lo solicitado

10. [BAD] - 21/01/2026 13:04 > lo que es inherente a las indicaciones medicas al alta debe estar arriba. puede haber algun tip (dejar media hora entre la toma de levotiroxina y otros remedios o desayuno) pero aparecen analgesicos y el horario. dice segun dolor pero aparece reglado el horario.

11. [PARTIAL] - 20/01/2026 20:09 > La recomendación principal sería: continuar estudios diagnósticos en centro apropiado, en contexto de internación. Eso sería lo correcto, aunque la paciente solicitó el egreso voluntario (contra sugerencia médica). Están bien indicadas en esta parte las pautas de alarma de consulta a Emergencias

12. [PARTIAL] - 20/01/2026 18:52 > " Traslado en ambulancia con médico acompañante a centro de rehabilitación cercano al domicilio." no es una recomendación al alta ya que se fue con internación domiciliaria. Falta la indicación de rehabilitación fonoaudiológica. Siempre se debe incluir las pautas de alarma para reconsulta

13. [BAD] - 20/01/2026 01:55 > rehabilitar no dice en la HC.

14. [PARTIAL] - 19/01/2026 23:00 > Uno de los motivos de persistencia de la internación fue la falla renal, y una de las condiciones para la externación con internación domiciliaria fue la posibilidad de control analítico de la

misma cada 48-72 hs, por lo que esto debe estar consignado en esta sección. Además siempre detallar las pautas de alarma en relación al cuadro actual para la reconsulta en un lenguaje que el paciente comprenda

15. [PARTIAL] - 19/01/2026 01:02 > Especificar las indicaciones de fonoaudiología. Siempre incluir las pautas de alarma para reconsulta en un lenguaje claro para el paciente

16. [PARTIAL] - 19/01/2026 00:40 > Siempre aclarar pautas de alarma con lenguaje que entienda el paciente

17. [PARTIAL] - 19/01/2026 00:31 > Siempre especificar pautas de alarma para reconsulta en un lenguaje claro para el paciente.

18. [PARTIAL] - 18/01/2026 17:28 > en la indicación / recomendación de alta NO va que en la internación se suspendió un medicamento, que además debe recomenzar.

19. [PARTIAL] - 17/01/2026 15:53 > Sería importante aclararle en el a epicrisis cuando tiene que ver al cirujano para que la controle

20. [PARTIAL] - 17/01/2026 14:22 > Agregaría pautas de alarma. Ej.: si presenta nuevamente sangrado, diarrea persistente, confusión, etc consultar a guardia.

21. [PARTIAL] - 17/01/2026 13:00 > Detallar específicamente qué pautas de alarma se deben tener en cuenta en base al cuadro clínico y redactarlas en un lenguaje que entienda el paciente

22. [PARTIAL] - 16/01/2026 23:48 > Siempre incluir pautas de alarma. En este caso tener en cuenta que la paciente se va de alta voluntaria, lo que aumenta notablemente los riesgos de mala evolución. Esto tiene que estar aclarado explícitamente y en lenguaje comprensible para el paciente

23. [PARTIAL] - 16/01/2026 13:57 > Siempre deben agregarse las pautas de alarma para reconsulta en lenguaje claro para que el paciente pueda interpetarlas en su domicilio y eventualmente reconsultar

24. [PARTIAL] - 16/01/2026 13:07 > Debería incluir cuidados de la sonda, dado que es un dispositivo cuyas complicaciones pueden generar una internación (como en este caso), y además las pautas de alarma para la reconsulta con un lenguaje que comprenda el paciente (ESTO ES IMPRESCINDIBLE)

25. [PARTIAL] - 16/01/2026 04:44 > Disnea cambiar por falta de aire.

- Las recomendaciónes al paciente debe evitar el lenguaje médico.

26. [PARTIAL] - 16/01/2026 04:23 > no tiene indicación de dieta blanda. No tiene como inventarlo asi que no es problema del sistema, sino de registro.

Patrones Identificados

Los siguientes patrones se identificaron analizando los comentarios de los evaluadores:

- **Contenido demasiado extenso**: Detectado en múltiples comentarios
- **Información faltante/incompleta**: Detectado en múltiples comentarios
- **Información inventada**: Detectado en múltiples comentarios
- **Información repetida/redundante**: Detectado en múltiples comentarios
- **Contenido confuso o erróneo**: Detectado en múltiples comentarios
- **Problemas con fechas/cronología**: Detectado en múltiples comentarios
- **Problemas de formato/estructura**: Detectado en múltiples comentarios

---

Historial de Actualizaciones

Fecha	Evento	Feedbacks Totales
06/02/2026 17:31	Documento generado	342

Referencias

- **Documento de Reglas de Oro**: REGLAS_GENERACION_EPC.md
- **Servicio de Insights**: `app/services/feedback_insights_service.py`
- **Colección MongoDB**: `epc_feedback`
- **Script de generación**: `scripts/generate_complete_learned_rules.py`

Documento generado automáticamente el 06/02/2026 17:31 Total de feedbacks procesados: 342